

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Enfermería



**Conocimientos y actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva
de madres primíparas de niños menores de seis meses que acuden
a un Centro de Salud Materno Infantil de Lima, 2025**

PROYECTO DE TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTORA

Torrico Obando Rosa Elena

ASESORA

Dra. Loli Ponce Rudi Amalia

Lima - Perú

2025

ÍNDICE

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA.....	1
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.2 OBJETIVOS	3
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	4
1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO	6
CAPÍTULO II: BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS	7
2.1 MARCO TEÓRICO	7
2.2 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS	24
2.3 METODOLOGÍA	25
2.3.1 Tipo, método y diseño de investigación.....	25
2.3.2 Descripción del área de estudio.....	25
2.3.3 Población y muestra	25
2.3.4 Variables	26
2.3.5 Operacionalización de variables.....	27
2.3.6 Técnicas e instrumentos	29
2.3.7 Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos	29
2.3.8 Consideraciones éticas	30
CAPÍTULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	32
3.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO	32
3.2 PRESUPUESTO	33
3.3 RECURSOS DISPONIBLES	34
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	34
ANEXOS	39

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Hace más de veinte años, la literatura científica ha destacado la relevancia de la lactancia materna, práctica que constituye un acto fisiológico y natural, propio de los mamíferos, como parte de una herencia biológica adaptativa específica de esta especie. (1)

Desde 1984 se reconocen los beneficios de la lactancia materna exclusiva frente a la lactancia parcial. Una revisión de investigaciones, evidenció que los lactantes menores de seis meses alimentados de manera parcial presentaban un riesgo de morir por diarrea 8.6 veces mayor en comparación con aquellos niños alimentados exclusivamente con leche materna. En los casos en que los lactantes no recibieron lactancia materna, el riesgo aumentaba hasta 25 veces. Un estudio desarrollado en Brasil en 1987 indicó que los bebés alimentados con lactancia parcial tenían un riesgo de mortalidad 4.2 veces mayor en comparación con los que recibían lactancia materna exclusiva, mientras que este riesgo se elevaba a 14.2 veces en los que no recibieron lactancia materna. Por otro lado, una investigación realizada en Dhaka, Bangladesh concluyó que, si durante los primeros cuatro meses los lactantes fueran alimentados exclusivamente con leche materna en lugar de parcialmente, se podría prevenir hasta un tercio de las muertes causadas por diarrea y neumonía. Además, se ha demostrado que mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida disminuye significativamente el riesgo de diarrea e infecciones respiratorias agudas, en comparación con duraciones de solo tres o cuatro meses. (2)

A nivel global, solo el 35% de los lactantes son alimentados exclusivamente con leche materna durante sus primeros cuatro meses. Esta baja tasa de lactancia materna exclusiva incrementa el riesgo de enfermedades en los bebés, debido a que las fórmulas infantiles no ofrecen el mismo nivel de protección inmunológica que proporciona la leche materna. (1)

En el caso de España, la prevalencia de la lactancia materna exclusiva es del 66.2% durante las primeras seis semanas de vida, disminuyendo al 53.6% a los tres meses y al 28.5% a los seis meses. Otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda y Francia presentan cifras aún más bajas,

con prevalencias que oscilan entre el 15% y el 43% a los tres meses, y entre el 0.2% y el 14% a los seis meses. (3)

Las estadísticas que corresponden a la situación en la región de las Américas entre los años 2015 al 2021, muestran que, alrededor del 55% de los bebés son amamantados dentro de la primera hora después de nacer, en América Latina y el Caribe. Así mismo, el 43% de los niños menores de seis meses son amantados exclusivamente de lactancia materna en promedio en América Latina y el Caribe. En el año 2012, la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) aprobó el objetivo global de nutrición, el cual consiste en aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida al menos al 50% para el año 2025. (4)

En Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), en el año 2023 el porcentaje de bebés que recibían lactancia materna exclusiva fue de 69.3%, registrando un crecimiento con respecto a los años 2022 y 2021, cuyas estadísticas fueron de 65.9% y 64%, respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con la última encuesta de dicha entidad en el primer semestre del año 2024, el 65.9% de lactantes menores de seis meses contó con lactancia materna exclusiva. (5)

En un estudio realizado por Ledesma ER, León LB, Hernández AF, Martínez MF, Majendie RP, se ha evidenciado que las características sociodemográficas inciden directamente en la duración de la lactancia materna exclusiva. Se ha observado que esta práctica tiende a ser más breve entre madres jóvenes, solteras, con bajo nivel socioeconómico, primíparas y con menor nivel educativo. Además, un factor determinante en la continuidad de la lactancia materna exclusiva es la situación laboral de la madre, la cual puede limitar el tiempo dedicado a la alimentación del bebé. (3)

En este contexto, Zamora, C. en el año 2022 realizó una investigación denominada “Nivel de conocimientos y actitudes sobre lactancia materna en madres adolescentes en el centro de salud de Pampa Grande 2022-2023”, en el cual concluye que la mayoría de madres adolescentes obtuvieron un nivel de conocimiento regular, seguido de un nivel de conocimiento bajo. Así mismo, la mayoría de madres tenían una actitud baja, seguida de una actitud regular. Debido a los resultados se sugiere que, generalmente, las madres adolescentes tienden a tener un conocimiento moderado y actitudes no muy favorables hacia la lactancia materna. (6)

En otra investigación, Chipana, R. en el año 2017 realizó un estudio denominado “Conocimientos y actitudes hacia la lactancia materna exclusiva que poseen las madres de niños menores de 4 meses que acuden al servicio de CRED en un Centro de Salud, Lima, 2017”, cuya conclusión refiere que la gran mayoría de madres desconocen acerca de la lactancia materna exclusiva y la mayoría de ellas tienen una actitud medianamente favorable para brindar a su niño lactancia materna exclusiva. (7)

En ese sentido, los cuidados de Enfermería orientados a favorecer la lactancia materna exclusiva surgen de la necesidad de brindar una atención integral, tanto a la madre como al bebé, involucrando también a la pareja, la familia y el contexto en el que se desarrolla la lactancia, de acuerdo con las necesidades identificadas por el profesional de Enfermería. Dentro de estas intervenciones, el bienestar físico y emocional de la madre constituye un aspecto importante para garantizar la continuidad de la lactancia idealmente hasta los dos años de edad, debido a los múltiples beneficios que esta práctica brinda al lactante, la madre y su entorno familiar. (8)

Es así que, como estudiante de Enfermería, durante el desarrollo de las prácticas pre-profesionales en diversos establecimientos de salud, se observó en madres primíparas de bebés menores de seis meses que, durante la práctica de lactancia materna, presentan un agarre “incorrecto” y una posición no favorecedora para la madre durante el amamantamiento, el cual traía consigo que el bebé no se sacie completamente y con ello muestre señales de hambre en cortos periodos de tiempo. Además, durante la entrevista, muchas de ellas optaban por rechazar la leche materna y proporcionarle fórmula láctea al bebé porque de esa manera “se iban a llenar más”. Ello nos lleva a formular diversas preguntas como ¿Conocen las madres primerizas acerca del agarre correcto durante la lactancia materna? ¿Las madres primerizas son conscientes de las actitudes alimenticias hacia sus bebés? En este contexto se presenta el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva de madres primíparas que acuden al servicio de CRED del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, 2025?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Determinar el nivel de conocimientos y las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva de madres primíparas que acuden al servicio CRED del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, 2025.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar el nivel de conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva de madres primíparas que acuden al servicio CRED del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena.
- Identificar las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva de madres primíparas que acuden al servicio CRED del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena.

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la lactancia materna está relacionada con la supervivencia de la especie humana desde tiempos remotos. En consecuencia, el ser humano necesita de la leche materna en las primeras etapas de vida, debido a que, en ausencia de esta, la supervivencia del recién nacido se vería comprometida. En este contexto, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han promovido activamente la práctica de la lactancia materna exclusiva (LME) durante los primeros seis meses de vida del bebé y su continuación como parte de una alimentación complementaria hasta los dos años de edad. (1)

Brindar leche materna como único alimento durante los primeros seis meses de vida y mantenerla como complemento hasta, al menos, los dos años de edad, es considerado el método más adecuado para favorecer un crecimiento y desarrollo infantil equilibrado, así como para disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en la infancia. Más de un millón de vidas infantiles podrían salvarse anualmente en todo el mundo si las madres llevaran a cabo la lactancia materna exclusiva durante, al menos, los cuatro primeros meses del bebé. (3)

Una nutrición adecuada durante la infancia y la primera niñez es fundamental para garantizar que los niños alcancen su máximo potencial en cuanto a crecimiento, salud y desarrollo. Una nutrición deficiente eleva el riesgo de contraer enfermedades y se relaciona, ya sea directa o indirectamente, con aproximadamente un tercio de las 9.5 millones de muertes estimadas en 2006 en menores de cinco años. Además, este problema puede contribuir al desarrollo de la obesidad infantil, el cual continúa en aumento en numerosos países. Las carencias nutricionales en etapas tempranas de la vida también se han asociado con alteraciones que afectan el crecimiento y la salud a largo plazo. La desnutrición en los primeros dos años de vida puede generar desnutrición crónica, lo que impedirá que el niño alcance su estatura potencial en la adultez, resultando en una talla

significativamente menor. En un estudio realizado por Pollitt E., Gorman K., Engle P., Rivera J. y Martorell R., se ha demostrado que los adultos que sufrieron desnutrición en la infancia presentan un menor rendimiento intelectual y una capacidad reducida para realizar trabajo físico. La alta prevalencia de niños desnutridos en una población repercute directamente en el desarrollo de un país, lo que evidencia que el impacto funcional de la desnutrición a nivel global es considerable. (2)

Adicionalmente, la leche materna proporciona al bebé una nutrición ideal durante su etapa de crecimiento, ya que contiene los minerales y nutrientes necesarios para cubrir sus necesidades durante los primeros seis meses de vida, además, incluye componentes inmunológicos, celulares y otros factores defensivos que ayudan a proteger al infante contra infecciones. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda comenzar la lactancia materna en la primera hora después del nacimiento, mantenerla de forma exclusiva durante los seis primeros meses de vida y continuarla hasta los dos años o más. (9) Así mismo, la lactancia materna exclusiva ofrece beneficios importantes para la madre, entre ellos, el retraso en el retorno de la fertilidad y una recuperación más rápida del peso corporal previo al embarazo. Es así que se ha observado que las mujeres que amamantan de forma exclusiva y frecuente presentan un riesgo menor al 2% de quedar embarazadas nuevamente durante los primeros seis meses posteriores al parto, siempre que continúe la amenorrea. (2)

Así mismo, la Resolución Ministerial N° 462-2015/MINSA, que establece la Guía Técnica para la Consejería en Lactancia Materna, dispone que la lactancia materna exclusiva debe ser proporcionada durante los primeros seis meses de vida del niño y continuada hasta los dos años de edad como alimentación complementaria para asegurar el crecimiento y desarrollo del lactante. De igual manera, se reporta que menos del 75% de lactantes dados de alta en el año 2015 han sido alimentados con lactancia materna exclusiva desde el nacimiento. (26)

La presente investigación es de gran relevancia, debido a que permitirá conocer los niveles de conocimientos y las actitudes que presentan las madres primerizas respecto a la lactancia materna exclusiva, lo cual es fundamental durante los primeros seis meses de vida del niño. Los resultados que se obtendrán en el estudio servirán como base y beneficiarán al personal de Enfermería que labora en el Centro de Salud, especialmente en el servicio de Crecimiento y Desarrollo, así como a las autoridades del establecimiento, con el fin de adoptar decisiones orientadas a fortalecer las

estrategias de promoción y apoyo a la lactancia materna exclusiva. Así mismo, permitirá al personal de Enfermería brindar una atención más cercana, empática y personalizada, considerando que las madres primerizas se encuentran atravesando por una etapa de vida que implica grandes cambios, interrogantes y necesidad de acompañamiento, lo que hace indispensable un cuidado integral y oportuno.

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO

La principal limitación del estudio abarca que sus resultados y conclusiones solo pueden ser aplicados a la población de madres primerizas con lactantes menores. Ello es debido a que las características propias de esta población, como su nivel de experiencia, conocimientos previos y contexto sociocultural pueden diferir de forma significativa de otras madres con distintos niveles de experiencia o hijos de mayor edad, lo cual restringe la generalización de estos hallazgos a otros grupos poblacionales.

CAPÍTULO II

BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 Antecedentes del estudio

Se realizó la recopilación de antecedentes en relación al tema presentado, entre los cuales se encuentran:

A. En el ámbito internacional:

Basrowi, R., Sulistomo, A., Adi, N., Widyahening, I. y Vandenplas, Y. en el año 2019 realizaron una investigación denominada “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la lactancia materna entre trabajadores administrativos y manuales en Indonesia”. Dicho estudio fue de tipo transversal. La muestra fue un total de 192 participantes, quienes fueron trabajadoras con hijos de entre 6 y 24 meses que trabajaban activamente en la fábrica o la oficina. El instrumento fue un cuestionario autoadministrado para la obtención de datos. Como conclusión, se obtuvo:

“Los trabajadores administrativos tienen un mejor conocimiento, actitud y práctica hacia la lactancia materna. Mejorar el conocimiento sobre los beneficios y el apoyo a la lactancia materna para las madres trabajadoras es una prioridad clave. Sin embargo, la promoción ante empleadores, gerentes y supervisores para facilitar la lactancia materna y brindar apoyo a los programas también fue crucial para el éxito de la práctica de la lactancia materna entre los trabajadores”. (10)

Hamze, L., Jinga, M. y Reifsnider, E. en el año 2019 publicaron una investigación nombrada “Conocimientos y actitudes hacia las prácticas de lactancia materna: una encuesta transversal de madres posparto en China”. El diseño fue transversal. La muestra estuvo compuesta por 324 madres posparto que completaron un cuestionario estructurado durante su estadía en las salas de maternidad de dos grandes hospitales docentes multiservicios, en Wuhan. En las conclusiones se observa que:

“Una actitud positiva y un buen conocimiento de la lactancia materna son fundamentales en el proceso de la lactancia materna. Por lo tanto, es importante brindar educación prenatal y posparto temprano, así como consejería periódica sobre lactancia materna, especialmente a las nuevas madres, para mejorar sus actitudes y conocimientos sobre la lactancia materna”.
(11)

Navas, J. en el año 2018 realizó un estudio titulado “Conocimientos, actitudes y prácticas de Lactancia Materna de madres con recién nacidos ingresados en el HAN en el periodo comprendido en Febrero a Marzo, 2018”. El tipo de estudio fue CAP descriptivo, transversal con enfoque mixto cualitativo y cuantitativo. Se seleccionó una muestra de 100 mujeres que acudieron durante el periodo de la investigación, a las cuales se les realizó una encuesta durante la vigilancia y tratamiento del puerperio y estancia del neonato en el servicio. Dentro de las conclusiones, se menciona:

“Un 52% presentaban un buen conocimiento acerca de qué es calostro, el inicio de la lactancia materna y el tiempo de duración de la LME. En general, la actitud que presentaban las madres fue una actitud favorable hacia la lactancia materna. En un 75% presentaron prácticas adecuadas en lactancia materna en los aspectos de dar lactancia materna exclusiva a sus bebés, inicio temprano de la lactancia materna, el tiempo adecuado de alimentación complementaria y de suspensión de la lactancia materna, tienen buenas prácticas de extracción de cólicos”. (12)

Flores, F. y Martínez, A. en el año 2018 publicaron un estudio titulado “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre lactancia materna exclusiva en mujeres de 15 a 49 años del barrio El Pochotillo de la Ciudad de Masaya durante el periodo enero-diciembre del 2016”. El estudio fue descriptivo, de corte transversal con enfoque cuali-cuantitativo. La muestra estuvo conformada de un total de 172 mujeres. La técnica fue la entrevista y el instrumento aplicado fue un cuestionario de preguntas cerradas. Dentro de las conclusiones se menciona que:

“Más del 70% de las entrevistadas mostraron un buen nivel de conocimiento, la principal fuente de donde obtuvieron información fue el personal de salud con más del 80%. Más del 70% de las entrevistadas tuvieron una actitud favorable ante la lactancia materna exclusiva. Más del 50% de las mujeres encuestadas practicaron la lactancia materna de forma regular, donde el 91.3% de las mujeres la administró durante los 6 meses completos”. (13)

García, N. y Hernández, P. en el año 2017 realizaron una investigación denominada “Conocimientos y actitudes de las madres ante la lactancia materna en un hospital IHAN”. Dicho estudio fue de tipo analítico y transversal. La muestra fue un grupo de 96 madres, de las cuales 52 fueron primíparas. Se elaboró un instrumento de recolección de datos que contenía secciones de datos sociodemográficos, antecedentes obstétricos, información familiar, características del recién nacido y un cuestionario acerca de los conocimientos, actitudes y prácticas relacionados con la lactancia materna. Las conclusiones fueron:

“Las mujeres del estudio demuestran tener conocimientos sobre la LM, aunque con lagunas en algunos puntos de interés. Tienen una actitud positiva o neutra hacia la LM en función al cuestionario utilizado. En el ámbito de la práctica, casi el 90% de las mujeres es dada de alta con LM exclusiva. Al tratarse de un hospital IHAN los resultados son favorables, pero mejorables en las tres dimensiones”. (14)

Mogre, V., Dery, M. y Gaa, P. en el año 2016 realizaron un estudio denominado “Conocimientos, actitudes y determinantes de la práctica de la lactancia materna exclusiva entre madres lactantes rurales de Ghana”. Dicho estudio fue transversal. La muestra estuvo conformada de 190 madres lactantes de zonas rurales con bebés de 0 a 6 meses que acudieron a un Centro de Salud de Ghana para recibir atención posnatal. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Como conclusión, se obtuvo que:

“El conocimiento y la actitud de las madres hacia la lactancia materna exclusiva fueron favorables, pero su práctica fue deficiente. Este estudio aporta evidencia adicional de que el conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva, la edad del niño y el nivel educativo materno son determinantes importantes de su práctica. Además de difundir mensajes de salud, los profesionales sanitarios deberían prestar más atención a las madres con menor nivel educativo, así como a los cuidadores de niños mayores”. (15)

B. En el ámbito nacional:

Moreano, S. en el año 2020 publicó una investigación nombrada “Conocimientos, creencias y actitudes en madres primerizas con lactancia materna exclusiva del Centro de Salud Perú III Zona, San Martín de Porres – 2019”. El enfoque del estudio fue cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 70 madres primerizas. La técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Dentro de las conclusiones se menciona:

“La lactancia materna está sufriendo intrascendencia, el nivel de conocimientos insuficientes, las creencias arraigadas que minimizan el gran valor proteico, que están en relación directa a los beneficios que podría darse y resaltar que aún prevalecen las buenas actitudes de disposición de apego de la madre con respecto al lactante”. (16)

Luque, Y. en el año 2020 publicó un trabajo de investigación denominado “Conocimientos y actitudes sobre la lactancia materna en madres adolescentes según condiciones sociodemográficas del Centro de Salud Cono Sur del distrito de Juliaca – San Román 2019”. Dicho estudio tuvo un diseño descriptivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 100 madres adolescentes entre 14 a 16 años de edad. Como instrumento se utilizó la encuesta y el método fue la encuesta. Como conclusiones, se obtiene:

“Se determinó que los conocimientos de las madres adolescentes sobre la lactancia materna son regulares y las actitudes son favorables y dudosas y para ambos casos existe asociación con la condición sociodemográfica de educación, obteniendo que el 96% de las madres adolescentes pertenece al estrato obrero y un 4% tiene condición sociodemográfica de estrato medio bajo”. (17)

Salas, H. en el año 2019 realizó un estudio titulado “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la lactancia materna exclusiva en madres lactantes usuarias, consultorios externos del Instituto Nacional de Salud del Niño, julio 2019”. El diseño que se empleó fue transversal y de nivel descriptivo. La muestra estuvo constituida por 573 madres lactantes. El instrumento para la recolección de datos que fue empleado fue la encuesta CAP, conformado por 33 preguntas cerradas. Las conclusiones evidencian:

“Poseen un nivel medio de conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva. Las madres lactantes usuarias poseen una actitud de indiferencia a su sistema de creencias y aspecto emocional. Ejecutan adecuadamente la práctica de la lactancia materna exclusiva”. (18)

Pomahuali, M. en el año 2019 realizó una investigación titulada “Conocimiento, actitudes y práctica en lactancia materna de las madres que acuden al Puesto de Salud Tres de Diciembre – Huancayo 2017”. El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y corte transversal. La muestra estuvo constituida por 30 madres de niños menores de seis meses que acudieron a la atención en el servicio de CRED. La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento un cuestionario. Dentro de las conclusiones, se destaca:

“De las variables conocimiento, actitud y práctica; el que destaca con nivel medio es el conocimiento (83.3%), identificándose mayor población con actitud negativa (60%) y mayor aún con práctica no adecuada (86.7%) de lactancia materna”. (19)

Asencios, N. en el año 2018, realizó una investigación nombrada “Conocimientos, actitudes y prácticas en la lactancia materna de las púerperas del Hospital Regional de Huacho, 2018”. El método de investigación fue cuantitativo, diseño no experimental, tipo descriptivo. Tanto la

población como la muestra estuvieron conformadas por 86 puérperas. La técnica utilizada fue la entrevista y el instrumento un cuestionario. Se concluye que:

“Los conocimientos encontrados en las puérperas mediatas se clasificaron en niveles, resultando un 39% es medio, seguido así en un 37% alto, 24% bajo. En la actitud el resultado de las puérperas encuestadas fue positiva en un 66%. Según los resultados, las puérperas realizan la práctica de la lactancia materna exclusiva en un 19%”. (20)

Villegas, M. en el año 2016 realizó un estudio titulado “Conocimiento, actitud y práctica sobre lactancia materna exclusiva de las madres con lactantes menores de 6 meses Puesto de Salud San Francisco de Chocan. Querecotillo. Agosto – noviembre 2016”. El enfoque fue cuantitativo, carácter descriptivo y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 64 participantes. La técnica empleada fue la entrevista y el instrumento un cuestionario. En las conclusiones se obtiene:

“El nivel de conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva prevaleció el nivel de conocimiento medio. Las actitudes de las madres con lactantes menores de 6 meses, es medianamente favorable y las prácticas adecuadas”. (21)

2.1.2 Referente Teórico

I) Aspectos teóricos conceptuales sobre Lactancia Materna Exclusiva

A. Definición de Lactancia Materna Exclusiva (LME)

La lactancia materna exclusiva se refiere a la alimentación del lactante únicamente con leche materna, ya sea directamente del pecho de la madre, extraída manualmente o proveniente de otra fuente humana. Además, se caracteriza porque no se le proporciona al bebé ningún otro tipo de alimento o bebida, ni siquiera agua, excepto las soluciones de rehidratación oral o preparados en forma de gotas o jarabes que contengan vitaminas, minerales o medicamentos. (22) La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan mantener la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida del niño, iniciarla dentro de la primera hora tras el parto, ofrecerla a libre demanda y evitar la administración de fórmulas infantiles. (23)

B. Frecuencia de las tomas

Se recomienda amamantar al bebé cada vez que éste lo solicite, ofreciéndole el pecho al menos ocho veces en un periodo de 24 horas, tanto de día como de noche, y alternando ambos senos en cada toma. A partir del tercer o cuarto mes de vida, es usual que el lactante requiera una mayor cantidad de leche materna, en consecuencia, será necesario aumentar tanto la frecuencia como la duración de las sesiones de amamantamiento. En esta etapa, la madre podría percibir que su bebé no queda completamente satisfecho, lo que puede llevar a la madre a introducir otros alimentos. Sin embargo, lo recomendable es incrementar la cantidad de tomas para cubrir sus necesidades nutricionales exclusivamente con leche materna. (24)

C. Variaciones en la composición nutricional de la leche materna

La leche humana es un fluido dinámico y adaptable, que responde a las necesidades cambiantes del bebé. Su composición varía conforme al crecimiento del niño, ajustándose para proporcionarle nutrientes y defensas que requiere en cada etapa. Gracias a su composición específica, es considerada el alimento más completo y seguro para los recién nacidos y lactantes. Sus componentes nutricionales, enzimáticos e inmunológicos, así como la proporción en la que se presentan, favorece el desarrollo y crecimiento óptimos en el niño. (25)

Se señala, además, que la composición de la leche materna varía entre diferentes mujeres, e incluso en una misma madre durante del día y durante una misma sesión de lactancia. Es importante que la madre comprenda que la leche materna no es una sustancia con fórmula fija, como es el caso de las fórmulas artificiales, sino que cambia constantemente para adaptarse a las necesidades nutricionales del bebé, las cuales evolucionan conforme crece. Este mismo proceso de adaptación se observa en la leche de madres de bebés prematuros, donde la fase del calostro puede extenderse hasta las primeras cuatro semanas, especialmente en el contenido inmunológico y proteico. (26)

D. Beneficios inmunológicos del calostro

Durante los primeros tres a cinco días luego del nacimiento, la leche materna se denomina calostro. En esta fase, su aspecto es un líquido espeso de tonalidad amarillenta, rico en proteínas, vitamina A y componentes inmunológicos esenciales, que contribuyen a proteger al recién nacido contra infecciones. Además, el calostro es ideal para el niño debido a que resguarda la mucosa intestinal gracias a la inmunoglobulina A secretora, lo cual evita que microorganismos dañinos se adhieran

y proliferen. Así mismo, actúa como un laxante natural que facilita la expulsión del meconio (es decir, las primeras heces del recién nacido) y ayuda a reducir la aparición de ictericia fisiológica. Aunque la cantidad de calostro producida puede ser limitada, es importante informar a la madre que tanto el volumen como el valor nutritivo del calostro son suficientes para cubrir las necesidades del bebé en esta primera etapa. (27)

E. Extracción manual de la leche

Tener conocimientos acerca de cómo extraer la leche materna resulta fundamental para asegurar que los niños puedan seguir recibiendo, incluso en situaciones en que se dificulte la lactancia directa. La técnica de extracción manual se destaca por su simplicidad, facilidad de aplicación, ausencia de costo y menor riesgo de contaminación, comparado con otros métodos. Este procedimiento puede durar entre 15 y 20 minutos, aproximadamente.

Antes de comenzar la extracción, la madre se debe lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón y secarlas con una toalla limpia de uso exclusivo. Para este fin, se utiliza un recipiente limpio, con tapa, de preferencia de vidrio o plástico resistente al calor.

Pasos para realizar la extracción manual de leche materna:

1. Realizar masajes circulares sobre el pecho, de arriba hacia abajo, para así favorecer la producción de leche.
2. Estimular los pezones con movimientos suaves, para activar los reflejos hormonales relacionados a la lactancia.
3. Sujetar el pecho colocando el pulgar por encima de la areola y los demás dedos por debajo, rodeando completamente la mama.
4. Presionar suavemente el pecho hacia el tórax para favorecer la salida de la leche.
5. Comprimir la zona externa de la areola con el pulgar, sin deslizarlo hacia el pezón.
6. Continuar con presiones rítmicas e intermitentes. Si la leche no fluye, no debe aumentarse la presión, sino mantener el ritmo constante para así inducir el reflejo de eyección, momento en el cual la leche saldrá en chorros pequeños durante varios minutos.

7. Cambiar la posición de los dedos alrededor del pecho es necesario para vaciar todas las zonas del mismo. Es importante evitar presionar o tirar únicamente del pezón, debido a que ello puede dificultar el reflejo de eyección. (27)

F. Conservación y consumo de la leche materna

- **Almacenamiento:** A temperatura ambiente (hasta 25°C) se conserva entre cuatro y ocho horas.
- **En una refrigeradora de una sola puerta:** La leche materna puede mantenerse congelada durante dos semanas. Sin embargo, en la parte inferior del congelador se conserva hasta por cinco días.
- **En una refrigeradora de dos puertas:** En el congelador, la leche materna puede mantenerse entre tres a seis meses. En la parte baja del congelador se conserva fresca durante cinco días.
- **Uso y calentamiento:** Para calentar la leche materna, se debe descongelar primero la leche más antigua a temperatura ambiente y mezclar suavemente con una cuchara limpia. Una vez descongelada, puede usarse como máximo dentro de 24 horas. La leche se calienta a baño María para evitar que pierda sus propiedades, colocando el recipiente en agua sin llegar a hervirla. Además, se debe considerar que la leche que ha sido entibiada no puede volver a utilizarse, mezclarse ni congelarse. (28)

G. Beneficios de la lactancia materna

El acto de amamantar, especialmente cuando se inicia justo después del nacimiento, favorece un reconocimiento recíproco entre la madre y su hijo, dando lugar a un vínculo afectivo sólido, conocido como “apego”. Este apego despierta en la madre intensos sentimientos de ternura, admiración y un fuerte impulso de proteger a su bebé. (25)

- **Para el niño**

Los bebés que son amamantados presentan un menor riesgo de padecer enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias, meningitis, septicemia e infecciones urinarias. La leche materna es esencial para fortalecer el sistema inmunológico del niño y contribuye significativamente a una buena salud en la etapa adulta.

Además, la lactancia materna favorece el desarrollo óptimo del paladar, los arcos dentales y otras estructuras faciales, lo cual reduce la posibilidad de desarrollar caries en comparación con los niños que no se alimentan de lactancia materna. El adecuado equilibrio entre succión, deglución y respiración durante los primeros meses es clave para un buen desarrollo dentomaxilofacial y para la maduración de funciones orales, como la masticación, la expresión facial y la articulación del lenguaje.

Los niños amamantados también suelen ser más activos, desarrollando un óptimo desarrollo psicomotor y con mayor capacidad de aprendizaje, es por ello que la lactancia materna se ha asociado con un coeficiente intelectual más elevado.

Cuando un bebé es amamantado adecuadamente, se satisfacen sus necesidades básicas de nutrición, afecto y calor humano, lo cual le genera bienestar y placer, que le permite sentirse amado y protegido, respondiendo con una actitud positiva, segura y feliz, desarrollando sanamente y en equilibrio la dimensión emocional. (25)

- **Para la madre**

La succión del bebé después del parto estimula la producción de oxitocina. Esta es una hormona que no solo facilita la eyección de la leche, sino que también provoca contracciones uterinas, que ayudan a prevenir hemorragias, haciendo que el útero recupere su tamaño normal. Este es un efecto que se mantiene durante el periodo de lactancia, favoreciendo una recuperación prolongada del útero.

Así mismo, una lactancia efectiva contribuye a que la madre pierda progresivamente el peso ganado durante el embarazo, debido a que el cuerpo utiliza estas reservas para producir leche. Es así que las hormonas involucradas, como la prolactina, influyen positivamente en la apariencia física, otorgándole a la madre una imagen más armoniosa.

La estimulación constante y el vaciado frecuente de los senos previenen la congestión mamaria y disminuyen los depósitos de grasa acumulados para la lactancia, lo que ayuda a conservar la firmeza y elasticidad del tejido mamario. Además, amamantar tiene un efecto protector frente a ciertos tipos de cáncer, como el de mama y el de ovario, ya que disminuye el riesgo de desarrollarlos.

La relación entre la madre y su hijo durante la lactancia, genera en la mujer una sensación de autoestima y estabilidad emocional, lo cual favorece su desarrollo integral como persona. (25)

- **Para la familia**

La lactancia materna contribuye a fortalecer los vínculos afectivos dentro del núcleo familiar, y actúa como un factor protector frente al maltrato infantil, debido a que, cuando una madre amamanta, se establece una relación emocional equilibrada y saludable con el niño.

Por otro lado, la lactancia materna exclusiva, combinada con la ausencia de menstruación, puede prevenir embarazos hasta en un 98% durante los primeros seis meses posteriores al parto, el cual es una estrategia natural de planificación familiar que se recomienda como opción inicial para espaciar los embarazos, por ende, también contribuye a la regulación natural del crecimiento poblacional. (25)

- **Para la sociedad**

Se estima que, si todas las madres en el mundo amamantarán a sus hijos al menos durante los primeros seis meses de vida, se podría prevenir la muerte de más de un millón de niños cada año, lo cual contribuye significativamente a la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil.

La lactancia materna también representa un importante ahorro económico para las familias, las instituciones de salud, los gobiernos y la sociedad en general. Ello se ve reflejado en la disminución de gastos asociados a la compra de fórmulas infantiles, biberones, chupetes y otros accesorios, así como en la reducción de costos por enfermedades infantiles, hospitalizaciones, atención médica y ausencias laborales de madres que deben cuidar a sus hijos enfermos.

Además, la lactancia aporta ventajas ecológicas, debido a que es un recurso natural, renovable, sustentable y amigable con el medio ambiente. Adicionalmente, no requiere de materias primas ni de procesos industriales, no produce residuos contaminantes ni implica costos de producción, empaques, distribución o almacenamiento. (25)

H. Indicadores de un agarre correcto

Se denomina agarre a la manera en que el bebé sujeta el pecho materno con la boca. Este puede ser adecuado o inadecuado y tiene un papel fundamental en el éxito de la lactancia. Un agarre correcto

garantiza una succión efectiva y previene molestias en la madre, mientras que un agarre deficiente puede generar dificultades en la alimentación y causar dolor o lesiones en el pezón. (29) Para dar inicio a una lactancia exitosa mediante el agarre correcto, el cuerpo del bebé debe quedar en paralelo al cuerpo de la mamá (barriga con barriga), la cabeza y el cuerpo del bebé están alineados y la cabeza queda a la altura y en frente del pecho de la madre. La barbilla está rozando el pecho y la nariz puede estar rozando también. El pezón y la mayor parte de la areola quedan dentro de la boca del bebé y el pezón no se siente adolorido ni sale deformado con forma de barra labial al finalizar la toma. La boca del bebé está abierta en su máxima amplitud posible, con los labios evertidos en forma de “boca de pez” y la lengua envuelve el pezón por debajo. La succión se inicia con un ritmo rápido para estimular la bajada de la leche, pero luego cobra un ritmo lento y profundo, con pausas momentáneas. No se escuchan chasquidos y, por el contrario, se puede oír cómo el bebé traga, pero ello no es excluyente de un agarre adecuado. Por último, las mejillas se observan redondeadas y sin hoyuelos.

II) Generalidades sobre Conocimientos y Actitudes

A. Definición de Conocimiento

El conocimiento representa una de las capacidades más importantes que posee el ser humano, ya que le posibilita comprender la esencia de los fenómenos que le rodean, sus relaciones y características, a través del uso del razonamiento. Desde este enfoque, el conocimiento puede entenderse como un conjunto de datos y representaciones abstractas conectadas entre sí, que se han acumulado gracias a la observación y la experiencia. En consecuencia, el conocimiento se origina a partir de la percepción sensorial del entorno, avanza hacia la comprensión y se perfecciona mediante la razón. Puede adquirirse de manera “a priori”, es decir, sin necesidad de recurrir a la experiencia, siendo suficiente el uso del pensamiento lógico. Del mismo modo, puede adquirirse de manera “a posteriori”, en cuyo caso es indispensable la experiencia para lograrlo. El proceso de adquisición del conocimiento involucra cuatro componentes: el sujeto, el objeto, la operación y la representación interna, lo que en conjunto compone el proceso cognitivo. (30)

Según Nieto y Rodríguez (2010) y Pérez, Galán y Quintanal (2012), el conocimiento posee una serie de características fundamentales, entre las que destacan:

- **Racional:** El conocimiento surge a partir de una facultad elevada propia del ser humano, que es la razón.
- **Objetivo:** Su finalidad es alcanzar la verdad objetiva, por lo cual debe reflejar fielmente la realidad, sin distorsionar ni modificar el objeto estudiado, permitiendo evidenciar sus propiedades y particularidades.
- **Intelectual:** Es un proceso que se basa en la lógica y se apoya en la sensación, percepción y representación para formular conceptos.
- **Universal:** El conocimiento tiene validez general, aplicable a cualquier persona y lugar.
- **Verificable:** Todo conocimiento puede ser comprobado, ya sea a través de la lógica o mediante la experimentación.
- **Sistemático:** Se estructura de forma ordenada, manteniendo coherencia en sus planteamientos.
- **Preciso:** Busca ser exacto, destacando los elementos esenciales de la realidad y diferenciándolos de forma clara de otros fenómenos u objetos.
- **Confiable:** Debido a que puede ser verificado, el conocimiento ofrece mayor nivel de certeza en su uso, en comparación con aquel que no puede ser comprobado. (30)

B. Teoría del conocimiento: El Empirismo

John Locke desarrolla su pensamiento filosófico basado en el empirismo, el cual surge como una crítica tanto al innatismo como al racionalismo. Su teoría gira en torno al compromiso con la experiencia directa y concreta, donde explica que el empirismo sostiene que la mente humana está limitada al ámbito de la experiencia, y que más allá de este límite solo existen interrogantes irresolubles o invenciones sin fundamento. A través de esta visión, Locke propone una moderación prudente frente a las aspiraciones de la razón humana. Su propósito fue comprender las verdaderas capacidades del ser humano, a través del análisis de sus propios límites. En su teoría del conocimiento, toma como referencia a Descartes, y establece que las ideas provienen únicamente de la experiencia, es decir, no son producto de una creación espontánea del intelecto, sino resultado de su receptividad frente a la realidad. Dicha realidad puede ser de tipo interno (como el yo) o externa (como el mundo natural), debido a esto las ideas pueden originarse en una u otra fuente. Las que surgen del sentido interno, como el pensamiento, la duda, la razón, el conocimiento o la voluntad, las denomina “ideas de reflexión”, ya que se relacionan con las funciones mentales. En

cambio, las que provienen del sentido externo, como los colores, el calor, la dureza o el sabor amargo, las denomina “ideas de sensación”. En tal sentido, Locke sigue el principio cartesiano, que sostiene que tener una idea implica percibirla, es decir, ser consciente de ella. Utiliza esta premisa para refutar la noción de las ideas innatas, debido a que, si realmente existieran, todos los seres humanos, incluidos los niños y las personas con discapacidad intelectual deberían poseerlas desde siempre. Por lo tanto, sostiene con firmeza que el conocimiento se origina a partir de las ideas y estas, a su vez, nacen de la experiencia. (31)

C. Definición de Actitud

Según Allport (1935), la actitud se comprende como un estado mental y neural de predisposición para responder, formado a partir de la experiencia, que influye de manera directa o dinámica en la conducta hacia los objetos y situaciones con los que una persona interactúa. Esta definición hace énfasis en que la actitud no es una conducta en sí, sino una preparación previa que orienta las respuestas conductuales frente a estímulos sociales. Por otro lado, Padua (1979) describe la actitud como una estructura duradera que integra procesos motivacionales, emocionales, perceptivos y cognitivos, relacionados con algún aspecto del entorno del individuo. Además, Festinger (1964) define la actitud como una organización estable de creencias y pensamientos, acompañada de una carga afectiva positiva o negativa hacia un objeto social específico, que predispone a una conducta coherente con dichas cogniciones y emociones. Por su parte, Severy (1974), la concibe como un constructo psicológico en el cual se integran creencias y emociones que influyen en la manera en que una persona responde, de forma positiva o negativa hacia otros individuos, objetos o instituciones. También se la considera como una tendencia a valorar un objeto o una idea en términos favorables o desfavorables. Estas definiciones coinciden en que la actitud es una disposición interna, que influye en la manera en que una persona actúa frente a personas, objetos o situaciones. Aunque la actitud por sí sola no determina una conducta específica, sí se relaciona estrechamente con ella. En este sentido, Summers (1976), refiere que la evaluación de las actitudes se basa en la observación de sus manifestaciones, es decir, en las respuestas valorativas que se expresan frente a opiniones vinculadas con creencias, emociones o comportamientos. (32)

D. Componentes de las Actitudes: Modelo Tridimensional

Según Mc Guire (1968), Breckler (1984), Judd y Johnson (1984) y Chaiken y Stangor (1987), el modelo tridimensional de las actitudes muestra que toda actitud está conformada por tres elementos fundamentales: el componente cognitivo, el componente afectivo y el componente conativo o conductual.

- **Componente Cognitivo:** Hace referencia a la manera en que se percibe el objeto de la actitud (Mc Guire, 1968), es decir, engloba las creencias, opiniones e información que la persona tiene acerca de dicho objeto (Hollander, 1978).
- **Componente Afectivo:** Puede entenderse como los sentimientos de simpatía o antipatía que una persona experimenta hacia el objeto de la actitud. (Mc Guire, 1968)
- **Componente Conductual:** Se refiere a las inclinaciones, predisposiciones o intenciones de conducta que una persona manifiesta frente al objeto de la actitud. (Rosenberg, 1960; Breckler, 1984) (33)

E. El Modelo de la Acción Planificada

Dentro del estudio de las actitudes, Ajzen y Fishbein son dos autores que han tenido un notable impacto, teniendo como objetivo principal predecir el comportamiento a partir de las actitudes, por lo que desarrollaron dos teorías fundamentales:

- **Teoría de la Acción Razonada**

Esta teoría critica la idea de que las decisiones se toman de manera completamente racional. Desde este contexto, la conducta es entendida como el resultado final de un proceso reflexivo, estructurado y lógico. Se considera que la conducta es el último eslabón de la cadena, siendo el primero la intención de actuar. Al analizar la conducta separándola de la intención que le precede, dejando un intervalo entre ambas, se observa cómo diversos factores externos pueden influir en el resultado final. Mientras más cercano sea el momento entre la intención y la acción, mayor será la probabilidad de que exista una relación positiva entre ambas. Por el contrario, si pasa demasiado tiempo, es menos probable que la conducta se lleve a cabo según la intención original, lo que genera una relación negativa entre ambas. Los autores también destacan que, para que haya una correspondencia significativa entre la intención de conducta y acción, ambas deben estar

formuladas con el mismo nivel de especificidad, es decir, deben referirse al mismo momento, contexto y objeto actitudinal. Cuando no coinciden en estos aspectos, es menos probable que haya una correspondencia entre lo que se quiere hacer y lo que finalmente se hace. Una vez identificada la relación entre la intención y la conducta, se debe considerar factores directamente vinculados con esa intención: la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva. El primer factor se basa en las creencias que se tiene sobre los resultados esperados de realizarla y en la valoración personal de cada una de esas consecuencias. Si se considera que dicha conducta llevará a resultados positivos, la actitud será favorable, caso contrario será negativa. El segundo factor se relaciona con las percepciones que una persona tiene sobre lo que opinan otras personas significativas respecto a si debería o no realizar una determinada acción o adoptar cierta actitud. La capacidad de esta teoría para predecir la conducta a partir de la intención es una de las más elevadas dentro del campo de la psicología social. (34)

- **Teoría de la Acción Planificada**

Dicha teoría surge al incorporar un nuevo elemento en la cadena que vincula la actitud con la conducta, que es el control percibido de la conducta, explicado como la percepción que tiene una persona sobre los obstáculos internos y/o externos que podrían dificultar o impedir la realización de una acción. Los obstáculos internos se relacionan con la percepción de falta de habilidades o competencias personales necesarias para llevar a cabo la conducta. En cambio, los obstáculos externos aluden a factores como la falta de recursos, accesibilidad limitada o la necesidad de cooperación de otras personas para poder ejecutar la acción deseada. En un inicio este componente se evaluaba de manera directa, lo cual generaba diversos inconvenientes metodológicos, por lo que, para superar estas limitaciones, Ajzen propuso una alternativa basada en el análisis de creencias. Este enfoque consiste en identificar lo que la persona cree respecto a la disponibilidad o ausencia de recursos, oportunidades y barreras que pueden facilitar o dificultar la ejecución de una conducta. Cada una de estas creencias se pondera mediante una multiplicación con la valoración que la persona hace sobre su capacidad de control frente a ese factor específico. Al final, la suma de todos estos productos proporciona una estimación del grado de control percibido que el individuo siente tener sobre la conducta. En definitiva, el control percibido junto con la norma subjetiva y la actitud hacia la conducta, conforma un conjunto de variables clave que permiten predecir con mayor precisión la conducta final de una persona. (34)

III) Teoría de Ramona Mercer

Ramona Mercer mediante su teoría denominada “Adopción del Rol Maternal”, destaca la importancia de que el personal de Enfermería, para brindar un cuidado holístico, debe considerar no solo a la madre, sino también a su entorno cercano (familia, trabajo, iglesia y otras instituciones de la comunidad), debido a que todos estos elementos influyen significativamente en la forma en que una mujer asume su rol como madre. Dicho proceso no ocurre con rapidez, sino que se trata de una transformación progresiva donde la madre desarrolla un vínculo afectivo con su hijo, adquiere competencias para cuidarlo adecuadamente y empieza a disfrutar y sentirse satisfecha con su nuevo rol. Esta transformación culmina en una fase en el cuál la madre se siente segura, conectada emocionalmente con su hijo y se siente plena con su rol, alcanzando así su identidad materna. Esta experiencia se ubica dentro de distintos niveles del entorno: el microsistema (relaciones cercanas), el mesosistema (interacciones entre esos entornos) y el macrosistema (incluye factores culturales y sociales más complejos). (35) Así mismo, Mercer señala que el proceso para el logro del rol materno se desarrolla en cuatro etapas fundamentales. En la primera etapa, la mujer empieza a imaginarse como una figura materna, prevé cómo cambiará su vida y visualiza a su futuro hijo, preparándose emocional y mentalmente para desempeñar ese nuevo rol. En la segunda etapa la madre se encuentra por primera vez con su bebé e inicia la adaptación a la experiencia real de la maternidad, en donde empieza a conocer a su hijo y a conocer las demandas que implica su cuidado. En el transcurso del tiempo, en la tercera etapa, la madre va aumentando la seguridad en sí misma y comienza a confiar en su capacidad para atender y responder a las necesidades de su hijo. Finalmente, en la cuarta etapa, la madre ya se siente una cuidadora competente y segura, además, ha integrado su rol como madre de manera plena, ha desarrollado un vínculo fuerte con su hijo y se siente realizada en la nueva etapa de su vida. (36)

IV) Rol de Enfermería

Referente al rol de Enfermería, la consejería en lactancia materna es pieza clave para promover, proteger y apoyar dicha práctica. A pesar de que todas las mujeres son biológicamente capaces de amamantar, salvo aquellas que presentan condiciones médicas que lo limitan, la práctica de lactancia materna está influenciada por diversos factores sociales, económicos, culturales e individuales. Estos factores actúan en distintos niveles y tienen un impacto directo en las decisiones y comportamientos de la madre en relación a la lactancia materna. En este sentido, el personal de

Enfermería desempeña un rol esencial al brindar consejería adecuada, abordando no solo los factores individuales en relación a las características de la madre y el niño, sino también los aspectos del entorno, como los servicios de salud, la comunidad y los centros laborales, así como los factores estructurales vinculados al contexto sociocultural y las políticas. En consecuencia, es necesario que la madre reciba información veraz y oportuna, acompañada de apoyo familiar, comunitario y del sistema sanitario. Por lo tanto, el personal de Enfermería fortalece el ámbito de Promoción de la Salud, ofreciendo consejería que fortalezca la confianza de la madre, mejore las técnicas de amamantamiento y contribuya a la prevención o solución de dificultades en relación con esta práctica, con la finalidad de garantizar el bienestar tanto de la madre como del niño. (26)

GLOSARIO

- **Madre Primeriza**

Mujer que experimenta la maternidad por primera vez, es decir, que ha tenido un solo hijo y atraviesa su primer proceso de cuidado y crianza. (37) En términos médicos, este estado se conoce como primípara, que hace referencia a la mujer que ha culminado un embarazo con un parto, alcanzando la viabilidad fetal por primera vez.

- **Lactante menor**

Niño menor a seis meses de edad. Durante este periodo, se enfatiza la importancia de la lactancia materna exclusiva para un crecimiento y desarrollo adecuados. (38)

2.2 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

Según Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M., en los estudios descriptivos no es indispensable plantear hipótesis, debido a que en dichos estudios se describen fenómenos o características de una población determinada y no se busca explicar las causas o sus efectos. (39) Por consiguiente, en el presente estudio no se formulará hipótesis, dado que se trata de una investigación de tipo descriptivo y no se busca establecer relación de causalidad entre las variables de estudio, sino únicamente identificar los conocimientos y las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva en madres primíparas.

2.3 METODOLOGÍA

2.3.1 Tipo, método y diseño de investigación

El presente proyecto de investigación será de enfoque cuantitativo, debido a que los resultados se obtendrán mediante técnicas de medición. El método será descriptivo, ya que el enfoque será la observación y registro de las variables a estudiar, sin establecer causa-efecto; y de corte transversal, a causa de que la recolección de datos se realizará en un solo tiempo y momento determinado. El diseño de estudio será no experimental, puesto que no se manipularán las variables en estudio.

2.3.2 Descripción del área de estudio

La investigación se llevará a cabo en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, ubicado en Jirón Junín 322 del distrito de Magdalena del Mar, en la provincia de Lima, en el departamento de Lima, Perú. El establecimiento es de categoría I-4 y pertenece a la Red de Salud Lima Ciudad de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro, dependiente del Ministerio de Salud (MINSA). Así mismo, el establecimiento está integrado a la Microred de Salud C.S Magdalena. (40) El Centro de Salud ofrece una variedad de servicios de salud, incluyendo atención médica general, especialidades médicas, servicios de urgencia y programas de Promoción de la Salud.

2.3.3 Población y muestra

La población estará conformada por el total de madres primíparas de niños menores de seis meses que acudan al control de Crecimiento y Desarrollo de sus niños(as) en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena. Según información proporcionada por el Área de Dirección de Monitoreo y Gestión Sanitaria de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, en el año 2024 se registraron un total de 117 nacimientos, lo que representa un promedio aproximado de 10 nacimientos mensuales (**VER ANEXO G Y H**). Considerando esta data, se estima que, durante el periodo de recolección de información, que abarcará cuatro meses, se podrá seleccionar una muestra de 40 madres primíparas, (**VER ANEXO D**) las cuales serán escogidas a través de muestreo no probabilístico por conveniencia, considerándose los siguientes criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión

- Mujeres que se hayan convertido en madres por primera vez.

- Madres de niños menores de seis meses que acudan al control de Crecimiento y Desarrollo de sus niños(as).
- Madres que deseen participar en el estudio y hayan firmado el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Madres imposibilitadas para brindar leche materna al niño.
- Madres con limitación psicológica.

2.3.4 Variables

- **Conocimientos sobre la Lactancia Materna Exclusiva**
Variable cualitativa nominal.
- **Actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva**
Variable cualitativa ordinal.

2.3.5 Operacionalización de variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIONES	INDICADORES	VALOR FINAL DE LA VARIABLE
Conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva	El conocimiento es un conjunto de datos y representaciones abstractas conectadas entre sí, que se han acumulado gracias a la observación y la experiencia (Neil y Cortez) acerca de la alimentación del lactante únicamente con leche humana, es decir, sin la inclusión de otros alimentos o líquidos. (MINSA Uruguay, UNICEF, RUANDI)	Aspectos generales de la leche materna Beneficios de la lactancia materna	- Definición - Frecuencia de las tomas - Variaciones en la composición nutricional de la leche materna - Beneficios inmunológicos del calostro - Extracción manual de la leche materna - Conservación de la leche materna - Indicadores de un agarre correcto - Beneficios para el niño - Beneficios para la madre - Beneficios para la familia - Beneficios para la sociedad	Bajo Medio Alto

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Los conocimientos constituyen un conjunto de información y representaciones abstractas interrelacionadas adquiridas a través de la observación y la experiencia que las madres primerizas poseen acerca de la lactancia materna exclusiva, que será medido a través de la técnica de la entrevista mediante un cuestionario, cuyo valor final será bajo, medio y alto.

Actitudes hacia la lactancia materna exclusiva	La actitud es un estado mental y neural de predisposición para responder, formado a partir de la experiencia, que influye de manera directa o dinámica en la conducta (Festinger) hacia la alimentación del lactante únicamente con leche materna, sin incluir otros alimentos o líquidos. (MINSA Uruguay, UNICEF, RUANDI)	Actitudes cognitivas	- Creencias sobre la lactancia materna - Opiniones acerca de la lactancia materna exclusiva - Intervenciones relacionadas con la lactancia materna	Aceptación Indiferencia Rechazo
		Actitudes afectivas	- Sentimientos de la madre al amamantar a su hijo	
		Actitudes conductuales	- Intención de la madre para amamantar	

DEFINICIÓN OPERACIONAL: Las actitudes se definen como una disposición mental y neural que se desarrolla a partir de la experiencia y que predispone a las madres primerizas a responder frente a la lactancia materna exclusiva, evaluado a través de la técnica de la entrevista mediante la escala Likert, cuyo valor final será aceptación, indiferencia y rechazo.

2.3.6 Técnica e instrumentos

Para la recolección de datos se utilizará como técnica la entrevista, la cual permitirá obtener información directa de las madres participantes. Los instrumentos a emplear serán un cuestionario estructurado y una escala para cada variable de estudio. **(VER ANEXO B)** Con respecto a la variable Conocimientos sobre la Lactancia Materna Exclusiva, se aplicará un cuestionario conformado por 14 preguntas, distribuidas en dos dimensiones, con el propósito de evaluar el Nivel de conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva, cuyos valores finales serán Bajo, Medio y Alto. En el caso de la variable Actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva, se utilizará una escala compuesta por 12 ítems organizadas en tres dimensiones, con el fin de medir las actitudes de las madres frente a la lactancia materna exclusiva. Esta escala se presentará bajo el formato de escala tipo Lickert, cuyas alternativas de respuesta serán: “Estoy en desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “Estoy de acuerdo”, lo cual permitirá responder al grado de Aceptación, Indiferencia o Rechazo hacia la lactancia materna exclusiva. **(VER ANEXO C Y E)**. Ambos instrumentos han sido sometidos a validez a través del juicio de 3 expertos en el área, evaluando los aspectos de Claridad y Relevancia **(VER ANEXO I)**. Luego de la aplicación del Coeficiente de Validez de Contenido (CVC) de Hernández Nieto, se obtuvieron, para la variable Conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva, los resultados de 0.90 y 0.91 en los aspectos de Claridad y Relevancia, respectivamente; así mismo, para la variable Actitudes hacia la Lactancia Materna exclusiva, se obtuvo el valor de 0.89 para ambos aspectos. Finalmente, se relacionaron dichos coeficientes con la interpretación de la validez y concordancia, correspondiendo así “Excelente” y “Bueno”, respectivamente **(VER ANEXO J)**.

2.3.7 Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos

- Se coordinará con la Escuela Profesional de Enfermería para obtener el permiso necesario para llevar a cabo la investigación.
- Se tramitará una solicitud a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro para obtener el permiso necesario para la aplicación del instrumento en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena.
- Se instalará un espacio adecuado dentro del área de estudio, que incluya una iluminación adecuada y esté libre de estruendos que puedan interferir durante la entrevista.

- Se solicitará a las participantes firmar el consentimiento informado, previa explicación detallada acerca de los objetivos, finalidad y beneficios del estudio, así como la resolución de dudas que puedan surgir.
- Se aplicará el cuestionario acerca de los conocimientos y las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva a las madres participantes, a través de una entrevista. Para el área de actitudes, se utilizará la estrategia de minicarteles de tres colores: verde, amarillo y rojo para facilitar la comprensión de la escala Lickert por parte de las participantes, siendo rojo la opción “Estoy en desacuerdo”, amarillo la opción “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, y verde la opción “Estoy de acuerdo”. Las respuestas serán registradas por la investigadora. El promedio de duración para la aplicación del instrumento será de 15 minutos. La recolección de datos se llevará a cabo tres días a la semana en el turno mañana (8:00 am – 12:00 pm) durante los meses de septiembre a diciembre.
- Se redactarán los datos obtenidos, se elaborará la matriz de datos y el libro de códigos en una hoja de cálculo del programa Excel 2016. Se presentarán los resultados a través de gráficos, considerando los valores finales según cada variable. Se realizará el análisis de datos haciendo uso de la estadística descriptiva y se considerará el marco teórico para el respectivo análisis de los resultados y la discusión.
- Se revisará y reajustará el informe final.
- Se presentará el proyecto culminado.
- Se aprobará el informe final.
- Se presentará y sustentará la tesis.

2.3.8 Consideraciones éticas

La investigación se llevará a cabo respetando los principios bioéticos de Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía y Justicia, garantizando así el bienestar y los derechos de las participantes.

- **Beneficencia**

Los resultados obtenidos de la presente investigación contribuirán a fortalecer las estrategias de Promoción de la Salud en el ámbito de la lactancia, lo cual beneficiará directamente a las madres y niños que acuden al Centro de Salud, así como al personal de Enfermería encargado de la atención en el servicio de Crecimiento y Desarrollo, lo cual contribuye indirectamente a

la mejora de los servicios de atención materno-infantil. Además, durante la entrevista se asegurará un ambiente seguro y respetuoso, procurando que la participación sea una experiencia positiva para las madres.

- **No Maleficencia**

Las preguntas del cuestionario estarán formuladas en un lenguaje claro y respetuoso, evitando aspectos que puedan generar incomodidad o malestar en las participantes, lo que garantizará que la investigación no cause daño psicológico ni emocional a las participantes. Así mismo, se les informará que se les permitirá retirarse del proceso en cualquier momento, sin que ello afecte la atención que reciben en el establecimiento de salud.

- **Autonomía**

Previo a la aplicación del cuestionario se brindará a cada participante una explicación detallada acerca de los objetivos, finalidad y beneficios del estudio, así como su derecho a decidir su participación. Solo aquellas participantes que otorguen su consentimiento informado por escrito serán incluidas en el estudio, garantizando su libertad para tomar decisiones y respetando su dignidad. **(VER ANEXO F)**

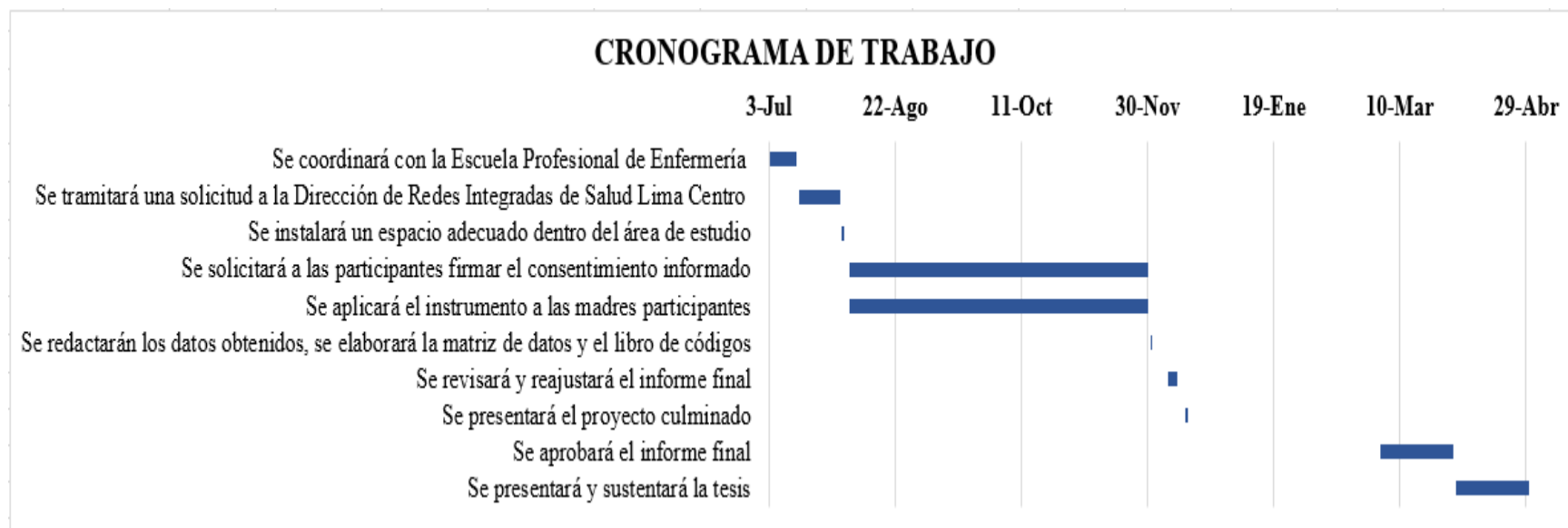
- **Justicia**

La selección de las participantes se realizará considerando únicamente a madres primerizas de niños menores de seis meses, sin distinción de raza, religión, nivel socioeconómico u otras características personales. La participación se realizará de forma anónima y la información recolectada será considerada confidencial. Dicha información será empleada exclusivamente para fines académicos.

CAPÍTULO III

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO



3.2 PRESUPUESTO

BIENES	CANTIDAD	SUBTOTAL
Laptop	1	S/. 1.500.00
Impresora	1	S/. 600.00
Paquetes de hojas bond	2	S/. 24.00
Útiles de escritorio	2	S/. 3.00
Archivador	1	S/. 12.00
SERVICIOS	CANTIDAD	SUBTOTAL
Internet mensual	5	S/. 400.00
Movilidad	-	S/. 100.00
TOTAL		S/. 2.639

3.3 RECURSOS DISPONIBLES

Recursos humanos:

- **Investigadora:** Torrico Obando, Rosa Elena
- **Asesor del proyecto:** Loli Poce, Rudi Amalia
- **Asesoría estadística:** Huamán del Pino, Liliana Concepción

Recursos materiales:

- Laptop
- Impresora
- Hojas bond
- Lapiceros
- Archivador

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ortiz YMB, Navarro CC, Ruíz GG. Lactancia Materna Exclusiva: ¿La Conocen Las Madres Realmente? Rev Cuid [Internet]. 2014 [citado 20 de abril de 2025];5(2):723-30. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359533181003>
2. La alimentación del lactante y del niño pequeño [Internet]. [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44310/9789275330944_spa.pdf?sequence=1
3. Ledesma ER, León LB, Hernández AF, Martínez MF, Majendie RP. Factores determinantes de la lactancia materna exclusiva: Policlínico «Aleida Fernández». 2015. Rev Habanera Cienc Médicas [Internet]. 2017 [citado 20 de abril de 2025];16(6):879-90. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180454489005>
4. Organización Panamericana de la Salud (OMS), Organización Mundial de la Salud (OMS) Región de las Américas. Lactancia materna y alimentación complementaria - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2025 [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria>
5. Ministerio de Salud (MINSA). El 65,9 % de menores de seis meses cuenta con lactancia materna exclusiva [Internet]. [citado 20 de abril de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1021904-el-65-9-de-menores-de-seis-meses-cuenta-con-lactancia-materna-exclusiva>
6. Zamora CK. Nivel de conocimientos y actitudes sobre lactancia materna en madres adolescentes en el centro de salud de Pampa Grande 2022-2023. [Internet]. [citado 27 de junio de

2025]. Disponible en: <https://repositorio.untumbes.edu.pe/server/api/core/bitstreams/2db93124-e4d9-4aa7-bdf6-7e81f9ac9081/content>

7. Chipana RM. Conocimientos y actitudes hacia la lactancia materna exclusiva que poseen las madres de niños menores de 4 meses que acuden al servicio de CRED en un centro de salud, Lima, 2017. [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/721c70fb-3caf-4d13-8b73-e07c6efe6081/content>

8. León Alayo ML, Huertas-Angulo F, León Alayo ML, Huertas-Angulo F. Cuidados de enfermería que fortalecen la lactancia materna en neonatos de un hospital. *Rev Cuba Enferm* [Internet]. junio de 2021 [citado 21 de abril de 2025];37(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03192021000200002&lng=es&nrm=iso&tlng=es

9. Organización Mundial de la Salud. Marco global de vigilancia en nutrición: directrices operacionales para el seguimiento de los progresos hacia el logro de las metas para 2025 [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2018 [citado 21 de abril de 2025]. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/272262>

10. Basrowi RW, Sulistomo AW, Adi NP, Widyahening IS, Vandenplas Y. Breastfeeding Knowledge, Attitude, and Practice among White-Collar and Blue-Collar Workers in Indonesia. *J Korean Med Sci* [Internet]. 24 de octubre de 2019 [citado 27 de junio de 2025];34(45):e284. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6875433/>

11. Hamze L, Mao J, Reifsnider E. Knowledge and attitudes towards breastfeeding practices: A cross-sectional survey of postnatal mothers in China. *Midwifery* [Internet]. 1 de julio de 2019 [citado 27 de junio de 2025];74:68-75. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613819300592>

12. Navas J. Conocimientos actitudes y prácticas de Lactancia de Materna de madres con recién nacidos ingresados en el HAN en el periodo comprendido en Febrero a Marzo 2018 [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/9120/1/98679.pdf>

13. Flores FE, Martínez AA. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRACTICAS SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DEL BARRIO EL POCHOTILLO DE LA CIUDAD DE MASAYA DURANTE EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016. [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/10347/>

14. García García N, Hernández Gutiérrez P. Conocimientos y actitudes de las madres ante la lactancia materna en un hospital IHAN. *Metas Enferm* [Internet]. 2018 [citado 27 de junio de 2025];21(1):6. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6274299>

15. Mogre V, Dery M, Gaa PK. Knowledge, attitudes and determinants of exclusive breastfeeding practice among Ghanaian rural lactating mothers. *Int Breastfeed J*. 2016;11:12.

[Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://internationalbreastfeedingjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13006-016-0071-z>

16. Sandra ML. CONOCIMIENTOS, CREENCIAS Y ACTITUDES EN MADRES PRIMERIZAS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA DEL CENTRO DE SALUD PERÚ III ZONA, SAN MARTÍN DE PORRES - 2019. [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uwiener.edu.pe/server/api/core/bitstreams/4f5b1ffe-eb9f-4a1d-9353-0443e8cd17fd/content>

17. Luque YN. CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES ADOLESCENTES SEGÚN CONDICIONES SOCIODEMOGRAFICAS DEL CENTRO DE SALUD CONO SUR DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN 2019. [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14082/13315/Luque_Quispe_Yeny_Nancy.pdf?sequence=1&isAllowed=y

18. Salas H. CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES LACTANTES USUARIAS, CONSULTORIOS EXTERNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO, JULIO 2019. [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13084/3845/SALAS%20RAMOS%20HUGO%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

19. Mangualaya MGP. CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PRÁCTICA EN LACTANCIA MATERNA DE LAS MADRES QUE ACUDEN AL PUESTO DE SALUD TRES DE DICIEMBRE – HUANCAYO 2017. [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unsa.edu.pe/server/api/core/bitstreams/49ffaad5-a8c0-4b00-9bec-811a5dba245d/content>

20. Asencios NH. Conocimientos, actitudes y práctica en la lactancia materna de las puérperas del Hospital Regional de Huacho, 2018 [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: https://repositorio.uap.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/20.500.12990/6618/Tesis_Conocimientos_Actitudes_Practica_Lactancia_Materna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21. Villegas M. Conocimiento actitud y practica sobre lactancia materna exclusiva de las madres con lactantes menores de 6 meses puesto de salud san francisco de chocan. Querecotillo. agosto - noviembre 2016. [Internet]. [citado 27 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.usanpedro.edu.pe/server/api/core/bitstreams/b390658a-7c93-4d36-acba-19a8dea28505/content>

22. Ministerio de Salud Uruguay, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), RUANDI. Norma Nacional de Lactancia Materna. [Internet]. [citado 7 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/sites/ministerio-salud-publica/files/documentos/publicaciones/Norma%20Nacional%20de%20Lactancia%20Materna.pdf>

23. Lactancia materna | UNICEF [Internet]. [citado 7 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.unicef.org/mexico/lactancia-materna>
24. Ministerio de Salud (MINSA). DOCUMENTO TÉCNICO CONSEJERÍA NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN DE SALUD MATERNO INFANTIL [Internet]. [citado 7 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/2784.pdf>
25. Organización Mundial de la Salud (OMS). LACTANCIA MATERNA CONTENIDOS TÉCNICOS [Internet]. [citado 7 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://platform.who.int/docs/default-source/mca-documents/policy-documents/operational-guidance/CHL-MN-67-01-OPERATIONAL-GUIDANCE-2010-esp-Manual-de-Lactancia-Materna.pdf>
26. Ministerio de Salud (MINSA). GUÍA TÉCNICA PARA LA CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA [Internet]. [citado 14 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/4173.pdf>
27. Ministerio de Salud (MINSA), Instituto Nacional de Salud (INS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Panamericana de la Salud (OPS). Lineamientos de Nutrición Materno Infantil del Perú. [Internet]. [citado 6 de mayo de 2025]. Disponible en: https://bvs.minsa.gob.pe/local/ins/158_linnut.pdf
28. Ministerio de Salud. Leche materna: extracción, conservación y consumo [Internet]. 2025 [citado 4 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.gob.pe/25545-leche-materna-extraccion-conservacion-y-consumo>
29. Consejeria en LM Curso de Capacitacion, Manuel del Participante 1993.pdf [Internet]. [citado 7 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/sites/default/files/Consejeria%20en%20LM%20Curso%20de%20Capacitacion%2C%20Manuel%20del%20Participante%201993.pdf>
30. Alan D, Cortez L. PROCESOS Y FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA [Internet]. [citado 14 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14231/1/Cap.3-Niveles%20del%20conocimiento.pdf>
31. Maria Estela Barrionuevo. JOHN LOCKE (1632 - 1704). SU VIDA, SU OBRA Y PENSAMIENTO. Disponible en: file:///C:/Users/Rosa%20Elena/Downloads/aviseras,+Gestor_a+de+la+revista,+887Barrionuevo.pdf
32. Escalante Gómez E, Repetto AM, Mattinello G. Exploración y análisis de la actitud hacia la estadística en alumnos de psicología. Liberabit [Internet]. enero de 2012 [citado 14 de mayo de 2025];18(1):15-26. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1729-48272012000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es

33. Ubillos S, Mayordomo S, Páez D. CAPÍTULO X ACTITUDES: DEFINICIÓN Y MEDICIÓN. COMPONENTES DE LA ACTITUD, MODELO DE LA ACCIÓN RAZONADA Y ACCIÓN PLANIFICADA. [Internet]. [citado 4 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.ehu.eus/documents/1463215/1504276/Capitulo+X.pdf>
34. Francisco Pacheco Ruiz. Actitudes. [Internet]. [citado 14 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1181505>
35. Alvarado L, Guarín L, Cañón-Montañez W. Adopción del rol maternal de la teórica Ramona Mercer al cuidado de enfermería binomio madre-hijo: reporte de caso en la unidad materno infantil. Rev Cuid [Internet]. 1 de diciembre de 2011 [citado 4 de junio de 2025];2(1). Disponible en: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/57>
36. Biscontini, Tyler. Maternal role attainment theory | EBSCO Research Starters [Internet]. [citado 4 de junio de 2025]. Disponible en: <https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/maternal-role-attainment-theory>
37. Valencia MC. MADRES PRIMERIZAS; UNA MIRADA DESDE LA CULTURA POPULAR COLOMBIANA. [Internet]. [citado 25 de junio de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.uniandes.edu.co/server/api/core/bitstreams/0c8442a8-9966-4e86-861a-170b442d3a3b/content>
38. Programa de Acciones Integrales para Mejorar la Nutrición Infantil en la Región San Martín (PAIMNI). Atención del niño/a Menor de 6 meses. [Internet]. [citado 25 de junio de 2025]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3340.pdf>
39. Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación [Internet]. McGraw Hill España; 2014 [citado 28 de junio de 2025]. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=775008>
40. Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados Geo Perú. INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - DISTRITO - MAGDALENA DEL MAR. [citado 29 de junio de 2025]. INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD. Disponible en: https://visor.geoperu.gob.pe/reportes/consulta_instituciones_salud.phtml?ocampo=gid&olayer=peru_hospitales&ovalor=00006196&utm_source=

ANEXOS

ANEXO A

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	ESTRUCTURA DE LA BASE TEÓRICA	METODOLOGÍA
¿Cuáles son los conocimientos y actitudes hacia la lactancia materna exclusiva en madres primíparas que acuden al servicio de CRED del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, 2025?	Objetivo General: Determinar los conocimientos y las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva de madres primíparas que acuden al servicio CRED del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, 2025. Objetivos Específicos: - Identificar los conocimientos sobre la lactancia materna exclusiva de madres primíparas que acuden al servicio CRED del Centro de Salud Materno Infantil Magdalena. - Identificar las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva de madres primíparas que acuden al servicio CRED del Centro de	I) Aspectos teóricos conceptuales sobre Lactancia Materna Exclusiva A. Definición de Lactancia Materna Exclusiva (LME) B. Frecuencia de las tomas C. Variaciones en la composición nutricional de la leche materna D. Beneficios inmunológicos del calostro E. Extracción manual de la leche F. Conservación y consumo de la leche materna - Almacenamiento - En una refrigeradora de una sola puerta - En una refrigeradora de dos puertas - Uso y calentamiento G. Beneficios de la lactancia materna - Para el niño - Para la madre - Para la familia	Tipo de investigación: Enfoque cuantitativo, descriptivo, de corte transversal Diseño de investigación: No experimental Población y muestra: La población estará conformada por el total de madres primíparas de niños menores de seis meses que acudan al control de Crecimiento y Desarrollo de sus niños(as) en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena. Se podrá seleccionar una muestra de 40 madres primíparas, las cuales serán escogidas a través de muestreo no probabilístico por conveniencia, considerándose criterios de inclusión y exclusión.

	Salud Materno Infantil Magdalena.	• Para la sociedad H. Signos de un agarre correcto II) Generalidades sobre Conocimientos y Actitudes A. Definición de Conocimiento B. Teoría del conocimiento: El Empirismo C. Definición de Actitud D. Componentes de las Actitudes: Modelo Tridimensional • Componente Cognitivo • Componente Afectivo • Componente Conductual E. El Modelo de la Acción Planificada • Teoría de la Acción Razonada • Teoría de la Acción Planificada III) Teoría de Ramona Mercer IV) Rol de Enfermería	Técnica: Encuesta Instrumento: Los instrumentos a emplear serán un cuestionario estructurado para la medición de la variable Conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva y una escala Lickert para la medición de la variable Actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva. Con relación a la variable conocimientos, se aplicará un cuestionario conformado por 14 preguntas cuyos valores finales serán “Bajo”, “Medio” y “Alto”. En cuanto a la variable actitudes, se utilizará una escala compuesta por 12 ítems organizados en tres dimensiones. Esta escala se presentará bajo el formato de escala tipo Lickert, cuyas alternativas de respuesta serán: “Estoy en desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y “Estoy de acuerdo”.
--	--------------------------------------	--	---

ANEXO B
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

INSTRUMENTO 1

DIMENSIONES	INDICADORES	PREGUNTAS
Aspectos generales de la leche materna	- Definición - Frecuencia de las tomas - Variaciones en la composición nutricional de la leche materna - Extracción manual de la leche materna - Conservación de la leche materna - Indicadores de un agarre correcto	1. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva? 2. ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener la lactancia materna exclusiva? 3. ¿En qué momento se recomienda iniciar la lactancia materna exclusiva después del parto? 4. ¿Con qué frecuencia se recomienda amamantar al bebé? 5. ¿Por qué varían los componentes de la leche materna? 6. ¿Cuál es el nombre de la primera leche que produce el pecho al inicio de la lactancia? 7. ¿Cuál es el primer paso para extraer manualmente la leche materna? 8. En Lima, ¿Hasta cuántos días se conserva la leche materna en la parte baja del refrigerador en verano? 9. ¿De qué manera se consigue que el niño tenga un buen agarre de la mama?
Beneficios de la lactancia materna exclusiva	- Beneficios inmunológicos del calostro - Beneficios para el niño - Beneficios para la madre - Beneficios para la familia - Beneficios para la sociedad	10. ¿Cuál es el beneficio más importante que le da al bebé la primera leche materna? 11. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para el bebé? 12. ¿Cuáles son las ventajas de la lactancia materna exclusiva para la madre? 13. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para la familia? 14. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para la sociedad?

INSTRUMENTO 2

DIMENSIONES	INDICADORES	ÍTEMS
Actitudes cognitivas	- Opiniones acerca de la lactancia materna exclusiva - Intervenciones relacionadas con la lactancia materna exclusiva - Creencias sobre la lactancia materna exclusiva	1. La lactancia materna exclusiva es la forma más práctica de alimentar a mi bebé. 2. Pienso que la lactancia materna exclusiva disminuye mi tiempo personal. 3. Amamantar a mi bebé durante sus primeros seis meses de vida le dará una mejor salud. 4. Pienso que dar solo la leche materna afecta negativamente mi salud física.
Actitudes afectivas	- Sentimientos de la madre respecto a la lactancia materna exclusiva	5. La lactancia materna exclusiva me hace sentir una conexión emocional con mi bebé. 6. Me siento presionada para mantener la lactancia materna exclusiva. 7. Estoy motivada a continuar con la lactancia materna hasta los seis meses. 8. A veces siento que la lactancia materna exclusiva me genera estrés.
Actitudes conductuales	- Intención de la madre para brindar lactancia materna exclusiva	9. Tengo la intención de ofrecerle a mi bebé lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses. 10. Cuando no estoy con mi bebé por varias horas, prefiero dejarle leche preparada (fórmula). 11. Estoy dispuesta a seguir las recomendaciones del personal de salud sobre la lactancia materna exclusiva. 12. Cuando no estoy con mi bebé prefiero dejarle refrigerada mi propia leche materna.

ANEXO C
INSTRUMENTOS PARA MEDIR LAS VARIABLES CONOCIMIENTOS Y
ACTITUDES

CUESTIONARIO

FECHA: ____/____/____

PRESENTACIÓN:

Estimada participante, mi nombre es Rosa Elena Torrico Obando, estudiante de la carrera profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad me encuentro realizando un estudio de investigación con el fin de conocer los conocimientos y las actitudes hacia la lactancia materna exclusiva de madres primerizas, en coordinación con el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena. Para llevar a cabo dicho proyecto, solicito su participación a través de sus respuestas sinceras y veraces, además, la información que usted brinde en el presente cuestionario será de carácter anónimo y sus respuestas serán manejadas de manera confidencial. Agradezco de antemano su colaboración.

INSTRUCCIÓN:

A continuación, voy a leer las preguntas y las alternativas de respuesta, usted deberá elegir la respuesta que crea conveniente o manifestar que desconoce.

I. DATOS GENERALES

A. DE LA MADRE

1. Edad:
 - a. 19 a 24 años
 - b. 25 a 30 años
 - c. 31 a 36 años
 - d. 37 a 42 años

2. Grado de instrucción:
 - a. Primaria completa
 - b. Primaria incompleta
 - c. Secundaria completa
 - d. Secundaria incompleta
 - e. Superior completa
 - f. Superior incompleta

3. Ocupación:
 - a. Trabaja
 - b. Estudia
 - c. Otro

3.1 Si usted trabaja, ¿cuál es su ocupación?: _____

3.2 ¿Está actualmente con licencia por maternidad? Sí () No ()

4. Estado civil:

- a. Soltera
- b. Casada
- c. Viuda
- d. Divorciada
- e. Conviviente

B. DEL NIÑO (A):

1. Fecha de nacimiento: ____/____/____

2. Edad del niño:

- a. 1 mes
- b. 2 meses
- c. 3 meses
- d. 4 meses
- e. 5 meses
- f. 6 meses

3. Sexo:

- a. Femenino
- b. Masculino

II. DATOS ESPECÍFICOS

A. CONOCIMIENTOS

1. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva?

- a. Es la alimentación del lactante con leche materna y otras leches
- b. Es la alimentación del lactante únicamente con leche materna
- c. Es la alimentación del lactante con leche materna y otros alimentos
- d. No conozco

2. ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener la lactancia materna exclusiva?

- a. Durante los seis primeros meses de vida del niño
- b. Durante los ocho primeros meses de vida del niño
- c. Durante los primeros doce meses de vida del niño
- d. No conozco

3. ¿En qué momento se recomienda iniciar la lactancia materna exclusiva después del parto?

- a. Al día siguiente
- b. Dos días después
- c. En la primera hora

d. No conozco

4. ¿Con qué frecuencia se recomienda amamantar al bebé?

- a. Tres veces al día
- b. Cuatro veces al día
- c. A libre demanda
- d. No conozco

5. ¿Por qué varían los componentes de la leche materna?

- a. Para aumentar la cantidad de agua
- b. Para brindar más nutrientes de los que el bebé necesita
- c. Para adaptarse a las necesidades del bebé
- d. No conozco

6. ¿Cuál es el nombre de la primera leche que produce el pecho al inicio de la lactancia?

- a. Calostro
- b. Leche de transición
- c. Leche madura
- d. No conozco

7. ¿Cuál es el beneficio más importante que le da al bebé la primera leche materna?

- a. Protege al bebé de enfermedades
- b. Brinda hidratación al niño
- c. Proporciona proteínas al niño
- d. No conozco

8. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para el bebé?

- a. Crecerá más rápidamente
- b. Fortalece el sistema inmune
- c. Se mantendrá alimentado
- d. No conozco

9. ¿Cuál es el primer paso para extraer manualmente la leche materna?

- a. Estimular los pezones
- b. Comprimir la areola
- c. Realizar masajes circulares
- d. No conozco

10. En Lima, ¿Hasta cuántos días se conserva la leche materna en la parte baja del refrigerador en verano?

- a. Tres días
- b. Cuatro días
- c. Cinco días
- d. No conozco

11. ¿De qué manera se consigue que el niño tenga un buen agarre de la mama?

- a. Cuando el bebé agarra solo el pezón
- b. Cuando el bebé agarra el pezón y la areola
- c. Cuando el bebé está separado de la madre
- d. No conozco

12. ¿Cuáles son las ventajas de la lactancia materna exclusiva para la madre?

- a. Favorece el aumento de peso
- b. Aumenta la fuerza física
- c. Previene la congestión mamaria
- d. No conozco

13. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para la familia?

- a. Permite que la familia prepare leche en fórmula para el bebé
- b. Establece una relación emocional entre la madre y el bebé
- c. Facilita que el bebé use el biberón desde los primeros días
- d. No conozco

14. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para la sociedad?

- a. Reduce la cantidad de niños enfermos y fallecidos
- b. Genera empleo en las fábricas de alimentos infantiles
- c. Favorece que se vendan más envases para alimentar al bebé
- d. No conozco

B. ACTITUDES

Ítem	Estoy en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Estoy de acuerdo
1. Considero que lactancia materna exclusiva es la forma más práctica de alimentar a mi bebé.			
2. Pienso que la lactancia materna exclusiva disminuye mi tiempo personal.			
3. Amamantar a mi bebé durante sus primeros seis meses de vida le dará una mejor salud.			
4. Pienso que dar solo la leche materna afecta negativamente mi salud física.			
5. La lactancia materna exclusiva me hace sentir una conexión emocional con mi bebé.			
6. Me siento presionada para mantener la lactancia materna exclusiva.			
7. Estoy motivada a continuar con la lactancia materna hasta los seis meses.			

8. A veces siento que la lactancia materna exclusiva me genera estrés.			
9. Tengo la intención de ofrecerle a mi bebé lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses.			
10. Cuando no estoy con mi bebé por varias horas, prefiero dejarle leche preparada (fórmula).			
11. Estoy dispuesta a seguir las recomendaciones del personal de salud sobre la lactancia materna exclusiva.			
12. Cuando no estoy con mi bebé prefiero dejarle refrigerada mi propia leche materna.			

Muchas gracias por su participación.

ANEXO D

TAMAÑO DE MUESTRA

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula de Población Finita para Variables Cualitativas. Según información estadística brindada por la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, la totalidad de nacimientos en el año 2024 en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena es 117, por ello, el promedio de nacimientos registrados por mes es 10. En consecuencia, se proyecta 36 madres primíparas distribuidas en tres meses de recolección de datos.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{d^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde:

N = 40 (población estimada)

Z = 1.96 (nivel de confianza 95%)

p = 0.5 (proporción esperada)

q = 0.5 (1-p)

d = 0.05 (margen de error del 5%)

Aplicando la fórmula:

$$n = \frac{40 \cdot 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.05^2 \cdot (40-1) + 1.96^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

$$n = 36.3$$

Del resultado, se deduce que para el presente estudio se necesita una muestra de aproximadamente 36 madres primíparas, quienes serán seleccionadas mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando los criterios de inclusión y exclusión.

ANEXO E
CÁLCULO DE LOS VALORES FINALES DE LA VARIABLE

1. VARIABLE CONOCIMIENTOS

Se puntuará de la siguiente manera:

- Respuesta correcta: 1 punto
- Respuesta incorrecta: 0 puntos

Por lo tanto:

- Puntaje máximo: 14 puntos
- Puntaje mínimo: 0 puntos

Considerando los valores finales de la variable:

Bajo	0 – 4
Medio	5 – 9
Alto	10 - 14

Primera dimensión (9 preguntas):

Bajo	0 – 3
Medio	4 - 6
Alto	7 - 9

Segunda dimensión (5 preguntas):

Bajo	0 – 1
Medio	2 – 3
Alto	4 – 5

2. VARIABLE ACTITUDES

Se puntuará de la siguiente manera:

- Estoy de acuerdo: 3 puntos
- Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 2 puntos
- Estoy en desacuerdo: 1 punto

Puntaje total posible:

- Máximo: $12 \times 3 = 36$ puntos
- Mínimo: $12 \times 1 = 12$ puntos

Considerando los valores finales de la variable:

Aceptación	28 - 36
Indiferencia	20 – 27
Rechazo	12 – 19

Primera dimensión (4 preguntas):

Aceptación	10 – 12
Indiferencia	7 – 9
Rechazo	4 – 6

Segunda dimensión (4 preguntas):

Aceptación	10 – 12
Indiferencia	7 – 9
Rechazo	4 – 6

Tercera dimensión (4 preguntas):

Aceptación	10 – 12
Indiferencia	7 – 9
Rechazo	4 – 6

ANEXO F
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación titulada “CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA DE MADRES PRIMÍPARAS DE NIÑOS MENORES DE SEIS MESES QUE ACUDEN A UN CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL DE LIMA, 2025”. Dicho estudio permitirá al personal de Enfermería fortalecer las estrategias de promoción y protección de la lactancia materna exclusiva.

Si usted desea participar en el estudio, la investigadora le realizará una serie de preguntas acerca de la lactancia materna exclusiva y, además, sobre su posición frente a la acción de lactar. Este procedimiento tendrá una duración aproximada de 15 minutos. Por el contrario, si usted no desea participar en el estudio, no será juzgada ni tratada de manera diferente en el establecimiento de salud ni en el servicio CRED, tanto a usted como a su niño.

Cabe destacar que usted puede dejar de participar en el estudio en cualquier momento. Además, el estudio se realizará de manera anónima y las únicas personas que podrán ver sus respuestas son las que forman parte del estudio.

Al firmar este documento usted acepta que está de acuerdo en participar en el estudio, que se le ha explicado la información contenida en este documento y que se han resuelto sus consultas. Si posteriormente le surgieran interrogantes acerca del estudio o sus derechos, puede comunicarse con la investigadora a través del teléfono celular 908511789.

HE LEÍDO Y COMPRENDIDO. HE QUEDADO SATISFECHA. MIS PREGUNTAS HAN SIDO RESPONDIDAS.

Lima, ____ de _____ del 2025.

Firma del Participante

Firma del Responsable del Estudio

ANEXO G

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE NACIMIENTOS EN EL
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL MAGDALENA DEL AÑO 2024**

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA"



Lima, 16 de junio del 2025

Asunto: Solicitud de información estadística sobre nacimientos en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena del año 2024

MC. Pedro Alejandro Cruzado Puente

Director General

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Yo, Rosa Elena Torrico Obando, identificada con DNI N° 72670630, domiciliada en Av. Paso de los Andes 1117 Urbanización La Florida Chica del distrito de Pueblo Libre en el departamento de Lima, número de celular 908511789, correo institucional rosa.torrico@unmsm.edu.pe, con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:

Que, actualmente vengo cursando el séptimo ciclo de la carrera profesional de Enfermería con código de estudiante 22010156 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y con el firme propósito de llevar a cabo mi investigación de fin de grado titulada "Conocimientos y actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva en madres primerizas de niños menores de seis meses que acuden a un Centro de Salud, Lima 2025" en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena, solicito la información estadística acerca del número de nacimientos registrados en el año 2024, por meses.

Ante lo expuesto, solicito acceder a mi petición.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rosa Elena Torrico Obando".

Firma

DNI N° 72670630

ANEXO H

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL MAGDALENA EN EL AÑO 2024



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Centro

DIRIS
LIMA CENTRO
MINSA

Firmado digitalmente por: ORTIZ CUBA,
VICTOR MANUEL
FIR 44837268 hard
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 24/06/2025 11:48:19-0500

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima, 24 de junio del 2025

INFORME N°0140-2025-SIS-VIT-ESTAD - OEISDI - DMGS/DIRIS-LC

A

ING. AVILES RODRIGUEZ DIEGO JUAN
AREA DE ESTADISTICA

ASUNTO : INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE NACIMIENTOS EN EL CENTRO
DE SALUD MATERNO INFANTIL MAGDALENA EN EL AÑO 2024

DE : LIC. ORTIZ CUBA VICTOR MANUEL
AREA DE SISTEMAS VITALES

ATENCIÓN : OFICINA EPIDEMIOLOGÍA, INTELIGENCIA SANITARIA Y
DOCENCIA E INVESTIGACION

REFERENCIA : SOLICITUDES-0-2025-SN

I INTRODUCCIÓN

La Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI es el órgano de apoyo del Ministerio de Salud, dependiente de la Secretaría General, responsable de implementar el gobierno electrónico; planificar, implementar y gestionar los sistemas de información del Ministerio; administrar la información estadística y científica en salud del Sector Salud; realizar la innovación y el desarrollo tecnológico, así como el soporte de los equipos informáticos del Ministerio de Salud. Asimismo, es responsable de establecer soluciones tecnológicas, en el ámbito de competencia del Ministerio de Salud, conforme lo señala el artículo 52 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2017-SA.

Mediante Resolución Ministerial N° 148-2012/MINSA, con Directiva Administrativa N°190-MINSA/OGEI-V.01. que es la Directiva Administrativa que establece el procedimiento para el registro del certificado nacido vivo. El "Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea" es un sistema web, producto de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), que permite que en los establecimientos de salud donde se atiendan partos, el recién nacido sea registrado de manera oportuna disminuyéndose la vulnerabilidad en el proceso de registro del nacimiento en sala de partos o cesárea, por el profesional que realiza la atención (Médico u Obstetra) generándose así el *Certificado del Nacido Vivo-CNV*.

El Sistema Registro del Certificado del Recién Nacido Vivo – CNV, no solo identifica a la madre, también facilita la identificación del profesional de la salud (Médico y Obstetra) que realiza la atención del parto o cesárea al contar con un código único, ambos casos por encontrarse vinculados directamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI). El Certificado del Nacido Vivo-CNV, producto del registro de información sobre el momento del parto, es requisito básico para contar con el Acta de Nacimiento y la inscripción del menor en los Registros Civiles. Posteriormente, le permitirá la obtención del DNI en las oficinas registrales de RENIEC. Igualmente el DNI le permite el acceso oportuno a los servicios de salud y a los programas sociales que el Estado ofrece. La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, mediante la Oficina de Epidemiología, Inteligencia Sanitaria y Docencia e Investigación mediante su equipo de Sistemas Vitales; se encarga del monitoreo de las plataformas SINADEF, como del CNV en las ipress de nuestra jurisdicción.



Firmado digitalmente por:
MARTOS CENTENO JAVIER
LEONCIO FIR 07866884 hard
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 20/06/2025 16:41:53-0500



Firmado digitalmente por:
AVILES RODRIGUEZ DIEGO JUAN
FIR 45576419 hard
Motivo: Soy el autor de este documento
Fecha: 24/06/2025 09:32:50-0500



CLAVE: 2eF1Etmp3

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la DIRIS LIMA CENTRO - DLC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://app1.dirislmacentro.gob.pe/sgd_consulta?url=verificar_documento

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autenticidad de las firmas pueden ser verificadas en: <https://app1.dirislmacentro.gob.pe/webvalidador.html>





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Centro

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

II. BASE LEGAL

- 2.1 Constitución Política del Perú
- 2.2 Ley General de Salud, Ley N° 26842
- 2.3 RM 148-2012/MINSA
- 2.4 Directiva Administrativa N°190-MINSA/OGEI-V.01
- 2.5 Ley 29733 Ley de Protección de Datos Personales.

III. ANALISIS

- 3.1 En la Carta enviada el 16 de junio del presente año por la Administrada Rosa Elena Torrico Obando, donde solicita la información estadística sobre los nacimientos en el Centro de Salud Materno Infantil Magdalena en el año 2024, para su investigación de grado.
- 3.2 Se debe precisar que toda información sobre los nacimientos de los centros maternos se encuentra reflejado en el Power BI, <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJmMmU0MjcxdktMzE1Zi00OTExLTlmNTktOGE1YzI1NDJmZWZlIiwidCI6Ijlk4MzlyM2QxLTE5N2QtNDAwYS04ZDVhLTE4ZWQ5ZTU5YjMzYyIsImMiOiR9>, herramienta digital, que manejan todos los encargados de RIS, de la DIRIS LIMA CENTRO.
- 3.3 De acuerdo a lo solicitado en el año 2024 el CMI. Magdalena, se registró en el CNV (Certificado de Nacido Vivo), la cantidad de 117 nacimientos registrados en el CNV.

Institución	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
MINSA	9	7	13	10	9	10	14	12	6	12	12	3	117
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL MAGDALENA	9	7	13	10	9	10	14	12	6	12	12	3	117
Total	9	7	13	10	9	10	14	12	6	12	12	3	117

Fuente CNV

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 De acuerdo a lo solicitado, se brinda la información de nacimientos registrados en el CNV, por el CMI Magdalena, por meses y el total del año 2024.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Se solicita remitir la documentación adjunta a la administrada como respuesta a su requerimiento sobre la información de nacimientos en el año 2024 en el CMI. Magdalena.

Es todo lo que tengo que informarle para su conocimiento y fines pertinentes

Documento firmado digitalmente por:
LIC.ORTIZ CUBA VICTOR MANUEL
RESPONSABLE SECTORISTA DE SISTEMAS VITALES
DIRIS LIMA CENTRO



CLAVE: 2eF1Etmp3

Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la DIRIS LIMA CENTRO - DLC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://app1.dirislimacentro.gob.pe/sgd_consulta?url=verificar_documento

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificaciones a la integridad del documento y la autenticidad de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en https://apps.mirapeu.gob.pe/web/validador_xhtml



ANEXO I

JUEZ EXPERTO 1

FORMATO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTO

Título del proyecto: Conocimientos y actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva de madres primíparas de niños menores de seis meses que acuden a un Centro de Salud Materno Infantil de Lima, 2025

Apellidos y nombres del estudiante: Torrico Obando Rosa Elena

INDICACIONES:

- Evalúe cada ítem o pregunta de manera cuantitativa (puntuación) y cualitativa (en observaciones), teniendo en consideración los criterios de claridad y relevancia.
- Coloque su calificación numérica según corresponda, en cada celda de la cuadrícula, considerando la siguiente escala:

1= Muy malo 2 = Malo 3 = Regular 4 = Bueno 5= Muy bueno

- En caso califica 1 o 2 puntos, describa la razón (es) y su sugerencia, en la columna de observaciones.

CRITERIO DE EVALUACION

- Claridad:** El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas; debido a la adecuación de su estructura y contenido para la población objetivo.
- Relevancia:** El ítem es esencial porque aporta información importante sobre un aspecto necesario de la dimensión que se pretende medir.

INSTRUMENTO 1

Ítem	Claridad					Relevancia					Observaciones
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva?					X					X	
2. ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener la lactancia materna exclusiva?				X						X	En primera instancia supuse que te referías a la cantidad de minutos que debe lactar el bebé por toma, pegado al pecho de la mamá. Aun así, al leer las opciones de respuesta ayudan a entender mejor la pregunta.
3. ¿En qué momento se recomienda iniciar la lactancia materna exclusiva después del parto?					X					X	
4. ¿Cuántas veces al día como mínimo se debe amamantar al bebé?					X					X	
5. ¿Por qué varían los componentes de la leche materna?					X					X	
6. ¿Cuál es el nombre de la primera leche que produce el pecho al inicio de la lactancia?					X					X	

7. ¿Cuál es el beneficio más importante que le da al bebé la primera leche materna?					X										X	
8. ¿Cuál es el primer paso para extraer manualmente la leche materna?					X										X	
9. En Lima, ¿Hasta cuántos días se conserva la leche materna en la parte baja del refrigerador en verano?					X										X	
10. ¿De qué manera se consigue que el niño tenga un buen agarre de la mama?					X										X	
11. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para el bebé?					X										X	
12. ¿Cuáles son las ventajas de la lactancia materna exclusiva para la madre?					X										X	
13. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para la familia?					X										X	
14. ¿Cuál es una ventaja de la lactancia materna exclusiva para la sociedad?					X										X	

SUGERENCIAS:

Rosa:

Considero que los ítems son claros y puntuales de acuerdo a lo que quieres evaluar en las madres y la información que deseas obtener al respecto. La única observación podría ser con el segundo ítem pero tus opciones múltiples ayudan a aclarar la pregunta.

INSTRUMENTO 2

Ítem	Claridad					Relevancia					Observaciones
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1. La lactancia materna exclusiva es la forma más práctica de alimentar a mi bebé.					X					X	
2. Pienso que la lactancia materna exclusiva disminuye mi tiempo personal.					X					X	
3. Amamantar a mi bebé durante sus primeros seis meses de vida le dará una mejor salud.					X					X	
4. Pienso que dar solo la leche materna afecta mi salud física.					X					X	
5. La lactancia materna exclusiva me hace sentir una conexión emocional con mi bebé.					X					X	
6. Me siento presionada para mantener la lactancia materna exclusiva.					X					X	
7. Estoy motivada a continuar con la lactancia materna hasta los seis meses.					X					X	
8. A veces siento que la lactancia materna exclusiva me genera estrés.					X					X	
9. Tengo la intención de ofrecerle a mi bebé lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses.					X					X	
10. Cuando no estoy con mi bebé por varias horas, prefiero dejarle leche preparada (fórmula).					X					X	
11. Estoy dispuesta a seguir las recomendaciones del personal de salud sobre la lactancia materna exclusiva.					X					X	
12. Cuando no estoy con mi bebé prefiero dejarle refrigerada mi propia leche materna.					X					X	

SUGERENCIAS:

Rosa:

Considero que las preguntas son claras e importantes para lo que quieres evaluar; también me parece prudente la cantidad de preguntas a resolver. Trata igual de encontrar el momento adecuado para que las madres puedan resolver ambos cuestionarios sin muchas distracciones y de forma eficaz en la medida de lo posible.

Por lo demás, tienes un tema muy interesante e importante que contribuirá mucho a mejorar la problemática que has identificado.

¡Muchos éxitos!

Nombre del Juez Experto: Leydy Claudia Ayala Hajar

Cargo: Lic. Esp. Enfermería Pediátrica

Fecha: Lima, 06 de Octubre del 2025



Leydy C. Ayala Hajar
LIC. ESP. EN ENFERMERIA PEDIATRICA
CEP 85212 REE: 26154

Firma

JUEZ EXPERTO 2

FORMATO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTO

Título del proyecto: Conocimientos y actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva de madres primíparas de niños menores de seis meses que acuden a un Centro de Salud Materno Infantil de Lima, 2025

Apellidos y nombres del estudiante: Torrico Obando Rosa Elena

INDICACIONES:

- A. Evalúe cada ítem o pregunta de manera cuantitativa (puntuación) y cualitativa (en observaciones), teniendo en consideración los criterios de claridad y relevancia.
 B. Coloque su calificación numérica según corresponda, en cada celda de la cuadrícula, considerando la siguiente escala:

1= Muy malo 2= Malo 3= Regular 4= Bueno 5= Muy bueno

- C. En caso califica 1 o 2 puntos, describa la razón (es) y su sugerencia, en la columna de observaciones.

CRITERIO DE EVALUACION

- **Claridad:** El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas; debido a la adecuación de su estructura y contenido para la población objetivo.
- **Relevancia:** El ítem es esencial porque aporta información importante sobre un aspecto necesario de la dimensión que se pretende medir.

INSTRUMENTO 1

Ítem	Claridad					Relevancia					Observaciones
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva?					X					X	
2. ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener la lactancia materna exclusiva?					X					X	
3. ¿En qué momento se recomienda iniciar la lactancia materna exclusiva después del parto?					X					X	Sugerencia: eliminar la palabra "exclusiva"
4. ¿Cuántas veces al día como mínimo se debe amamantar al bebé?					X					X	
5. ¿Por qué varían los componentes de la leche materna?					X					X	
6. ¿Cuál es el nombre de la primera leche que produce el pecho al inicio de la lactancia?				X					X		
7. ¿Cuál es el beneficio más importante que le da al bebé la primera leche materna?				X					X		
8. ¿Cuál es el primer paso para extraer					X					X	

JUEZ EXPERTO 3

FORMATO DE VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTO

Título del proyecto: Conocimientos y actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva de madres primíparas de niños menores de seis meses que acuden a un Centro de Salud Materno Infantil de Lima, 2025

Apellidos y nombres del estudiante: Torrico Obando Rosa Elena

INDICACIONES:

- A. Evalúe cada ítem o pregunta de manera cuantitativa (puntuación) y cualitativa (en observaciones), teniendo en consideración los criterios de claridad y relevancia.
- B. Coloque su calificación numérica según corresponda, en cada celda de la cuadrícula, considerando la siguiente escala:

1= Muy malo 2 = Malo 3 = Regular 4 = Bueno 5= Muy bueno

- C. En caso califica 1 o 2 puntos, describa la razón (es) y su sugerencia, en la columna de observaciones.

CRITERIO DE EVALUACION

- **Claridad:** El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuadas; debido a la adecuación de su estructura y contenido para la población objetivo.
- **Relevancia:** El ítem es esencial porque aporta información importante sobre un aspecto necesario de la dimensión que se pretende medir.

INSTRUMENTO 1

Ítem	Claridad					Relevancia					Observaciones
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1. ¿Qué es la lactancia materna exclusiva?					5					5	MUY CLARO.
2. ¿Cuánto tiempo se recomienda mantener la lactancia materna exclusiva?					5					5	ADECUADO
3. ¿En qué momento se recomienda iniciar la lactancia materna exclusiva después del parto?					5					5	CLARAMENTE FORMULADO
4. ¿Cuántas veces al día como mínimo se debe amamantar al bebé?				4						5	REFORMULAR: ¿CON QUE FRECUENCIA SE RECOMIENDA AMAMANTAR AL BEBÉ?
5. ¿Por qué varían los componentes de la leche materna?					5					5	EVIDENCIA EL CONOCIMIENTO DEL PROCESO BIOQUÍMICO.
6. ¿Cuál es el nombre de la primera leche que produce el pecho al inicio de la lactancia?					5					5	COHERENTE CON TERMINOLOGÍA CLÍNICA "CALOSTRO"
7. ¿Cuál es el beneficio más importante que le da al bebé la primera leche materna?					5					5	MIDE COMPRENSIÓN SOBRE INMUNOPROTECCIÓN
8. ¿Cuál es el primer paso para extraer					5					5	PRECISO

5. La lactancia materna exclusiva me hace sentir una conexión emocional con mi bebé.					5					5	MUY RELEVANTE, COPIA DIMENSIÓN AFECTIVA.
6. Me siento presionada para mantener la lactancia materna exclusiva.					5					5	VALIOSA PARA DETECTAR FACTORES SOCIOCULTURALES
7. Estoy motivada a continuar con la lactancia materna hasta los seis meses.					5					5	CORRECTO, MIDE ACTITUD PROACTIVA.
8. A veces siento que la lactancia materna exclusiva me genera estrés.					5					5	ITEM SENSIBLE Y NECESARIO, REFLEJA DIMENSIÓN EMOCIONAL.
9. Tengo la intención de ofrecerle a mi bebé lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses.					5					5	EXCELENTE/EVALÚA INTENCIÓN CONDUCTUAL
10. Cuando no estoy con mi bebé por varias horas, prefiero dejarle leche preparada (fórmula).					5					5	PERTINENTE, MIDE CONFLICTO ENTRE PRÁCTICOS Y CONOCIMIENTOS
11. Estoy dispuesta a seguir las recomendaciones del personal de salud sobre la lactancia materna exclusiva.					5					5	CLAVE, EVALÚA CONFIANZA EN EL SISTEMA DE SALUD
12. Cuando no estoy con mi bebé prefiero dejarle refrigerada mi propia leche materna.					5					5	MUY BUENA, REFLEJA INTERVALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DECUADOS

SUGERENCIAS:

- EXCELENTE ESTRUCTURA LIKERT
- REFLEJA LAS TRES DIMENSIONES ACTITUDINALES: COGNITIVA, AFECTIVA Y CONDUCTUAL
- SE RECOMIENDA MANTENER NEUTRALIDAD SEMÁNTICA ENTRE ÍTEM POSITIVOS Y NEGATIVOS PARA EVITAR SESGO DE RESPUESTA

CAROLINA ESTHER CHAVEZ VILLANUEVA

Nombres y apellidos del juez-experto:

DNI u otro: 40826608

Cargo: ENFERMERA ASISTENCIAL-SERVICIO NEONATOLOGÍA HJVBC

Fecha: 03-11-2025

Firma: _____

[Firma manuscrita]
 LIC. CAROLINA CHAVEZ VILLANUEVA
 ENFERMERA ESP. NEONATOLOGÍA
 C.E.P. 44120

ANEXO J

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE HERNÁNDEZ NIETO

Conocimientos sobre Lactancia Materna Exclusiva

Claridad

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

(Hernandez-Nieto, 2011)

3 JUECES

Item	J1	j2	j3	Σx_{ij}	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
2	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
3	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
4	5	5	4	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
5	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
6	5	4	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
7	5	4	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
8	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
9	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
10	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
11	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
12	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
13	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
14	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
							Σ	13.2153333
n de ítems						14	CVCt	0.9440
							CVCtc	0.9070

Relevancia

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

(Hernandez-Nieto, 2011)

3 JUECES

Item	J1	j2	j3	Σx_{ij}	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
2	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
3	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
4	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
5	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
6	5	4	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
7	5	4	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
8	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
9	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
10	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
11	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
12	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
13	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
14	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
							Σ	13.3486667
n de ítems						14	CVCt	0.9535
							CVCtc	0.9165

Actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva

Claridad

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

(Hernandez-Nieto, 2011)

3 JUECES

Item	J1	j2	j3	Σ xij	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	5	4	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
2	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
3	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
4	5	4	4	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
5	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
6	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
7	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
8	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
9	5	3	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
10	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
11	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
12	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
				Σ				11.2226667
				n de ítems				12
				CVCt				0.9352
				CVCtc				0.8982

Relevancia

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

(Hernandez-Nieto, 2011)

3 JUECES

Item	J1	j2	j3	Σ xij	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	5	4	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
2	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
3	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
4	5	3	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
5	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
6	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
7	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
8	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
9	5	3	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
10	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
11	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
12	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
				Σ				11.2226667
				n de ítems				12
				CVCt				0.9352
				CVCtc				0.8982



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN
(AEE-CEI)

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0328-2025

En Lima, a los dieciocho y uno días del mes de julio, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Tesis de Pregrado titulado: **"Conocimientos y actitudes hacia la lactancia materna exclusiva en madres primíparas de niños menores de seis meses que acuden a un Centro de Salud Materno Infantil de Lima, 2025"** presentada por **Rosa Elena Torrico Obando** con código 22010156, de la escuela profesional de enfermería, para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería, en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

"El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 17 de setiembre de 2026"

Lima, 18 de setiembre de 2025




JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL C.E.I. / F.M. / U.N.M.S.M.
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CODIGO DOCENTE: 0A3079
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zagarra
Presidente del CEI/FM/UNMSM



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima 24 de octubre del 2025

CARTA N°0165-EPE-FM-2025

Dr.

JOSE ENRIQUE MATOS QUINTANILLA

Médico Jefe

CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL MAGDALENA

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle y a la vez, manifestarle que la estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería:

- **Srta. Rosa Elena Torrico Obando**, identificada con número de DNI N° **72670630**

La cual viene desarrollando su proyecto de investigación:

"Conocimientos y actitudes hacia la Lactancia Materna Exclusiva de madres primíparas de niños menores de seis meses que acuden a un Centro de Salud Materno Infantil de Lima, 2025"

En tal sentido, se solicita muy amablemente brinde usted o autorice a quien corresponda las facilidades necesarias para que la mencionada estudiante pueda recolectar información y aplicar su instrumento durante los meses de octubre a diciembre del 2025.

Sin otro particular y agradeciéndole anticipadamente por todas las facilidades que brinde, me despido de usted.

Muy Atentamente.

DRA. JUANA MAILDE CUBA SANCHO
Directora
Escuela Profesional de Enfermería
UNMSM